KLIRA

Sistem Informasi Klinik & Rekam Medis Elektronik

Panduan Fitur dan Tutorial Lengkap

Dilengkapi hasil simulasi alur rawat jalan pada aplikasi yang berjalan

Disusun 10 November 2026 · Klinik contoh: Klinik Bhakti Rahayu

Isi panduan

Bagian	Isi
1	Mengenal Klira: cakupan, status pembangunan, prinsip tampilan
2	Masuk, akun, dan hak akses
3	Peta menu: 14 halaman dan tab-nya
4	Fitur per halaman (dengan tangkapan layar)
5	Hasil simulasi: satu pasien rawat jalan dari registrasi sampai arsip (10 langkah)
6	Tutorial tugas lain: rawat inap, lab, klaim JKN, akun, hak pasien, shift kasir
7	Tutorial per peran kerja
8	Catatan hasil simulasi, keterbatasan, dan pemecahan masalah
9	Lampiran: daftar modal, kata kunci, pintasan

Cara membaca. Bagian 5 adalah hasil menjalankan aplikasi sungguhan di database pengembangan (klira_dev): semua nomor, status, dan tampilan di bagian itu muncul dari aplikasi, bukan rancangan. Bagian 6 memakai tangkapan layar modal yang dibuka tanpa disimpan; langkahnya diambil dari isian yang tampil di layar, bukan dieksekusi penuh. Bagian 4 dan 7 merangkum kemampuan menurut dokumen rancangan dan layar yang teramati.

1. Mengenal Klira

Klira adalah aplikasi web untuk klinik pratama (rawat jalan, rawat inap, farmasi, laboratorium, peserta JKN/BPJS). Satu aplikasi melayani banyak fasilitas kesehatan (multi-tenant); satu fasilitas setara satu Organization ID SATUSEHAT. Data dan cadangan disimpan di Indonesia.

Cakupan

Tahap	Modul
1 (dibangun)	Pendaftaran, rawat jalan, rawat inap, farmasi, laboratorium, klaim JKN/BPJS, pelindungan data pribadi (PDP)
1 (menunggu pihak ketiga)	Integrasi SATUSEHAT, master terminologi resmi (ICD-10, ICD-9 CM, LOINC, SNOMED, UCUM)
2 (rencana)	Modul program FKTP (ANC, imunisasi, MTBS, skrining PTM, TB, gizi) dan klaim elektronik SATUSEHAT
Ditunda	IGD

Status pembangunan (dokumen/progres.md)

- **66 butir selesai** dan lolos uji otomatis: fondasi, daftar pasien, registrasi, kunjungan, pemeriksaan klinis SOAPIE, penunjang, persetujuan tindakan, farmasi, kasir, rekam medis, rawat inap, klaim JKN, pelindungan data, beranda tugas.
- **Belum** (menunggu pihak ketiga): halaman SATUSEHAT beserta konfigurasi, antrean kirim, sinkronisasi KFA/master, KYC, dan registrasi sistem. Halaman SATUSEHAT saat ini hanya menampilkan "Halaman ini segera tersedia".
- Master terminologi memakai data contoh/terbatas sampai berkas resmi tersedia; katalog KFA dan LOINC statis sudah ada.

Prinsip tampilan

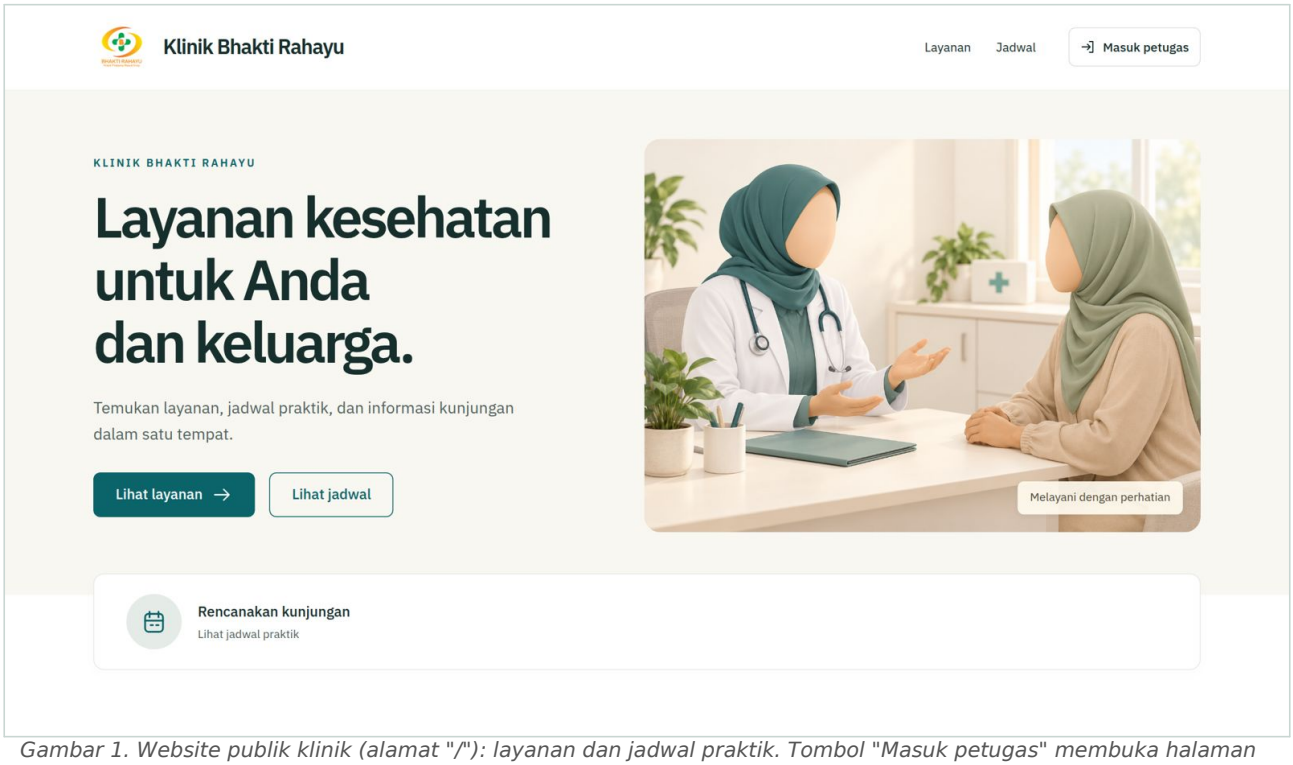
- **Satu tempat per pekerjaan.** Pekerjaan per pasien dibuka sebagai modal dari Daftar pasien; halaman lain hanya untuk pekerjaan non-per-pasien (master, stok, rekap, klaim, pengaturan).

- **Modal bertahap** menampilkan "langkah X dari Y", daftar langkah yang bisa diklik, ringkasan pasien (alergi, diagnosis aktif, tanda vital) yang tetap terlihat, dan **draf otomatis** (lihat bagian 8).
- **Menu mengikuti akun.** Menu hanya menampilkan halaman yang diizinkan; akun yang merangkap beberapa jenis melihat gabungan aksesnya.
- **Peringatan, bukan blokir.** Hal berisiko (stok kurang, penutupan tanpa bayar, izin berisiko) memunculkan peringatan dengan alasan wajib yang tercatat di log audit.
- **Perubahan klinis berversi**, tidak ada penghapusan. Waktu disimpan UTC+00; NIK 16 digit.
- Tema **Terang / Sistem / Gelap** tersedia di kanan atas semua halaman.

2. Masuk, akun, dan hak akses

Masuk pertama kali

1. Buka alamat aplikasi, pilih **Masuk petugas** di pojok kanan atas halaman publik (atau buka `/masuk`).
2. Admin vendor membuat klinik dan satu akun **Pimpinan** pertama dengan username dan kata sandi awal yang diberikan penyedia.
3. Saat login pertama, **username dan kata sandi wajib diganti**; fitur lain terkunci sebelum diganti, dan kredensial awal tidak berlaku lagi.
4. Setelah masuk, akun klinis dan administrasi langsung ke **Daftar pasien**; admin IT, admin vendor, dan petugas PDP ke **Beranda tugas**.



Gambar 1. Website publik klinik (alamat "/"): layanan dan jadwal praktik. Tombol "Masuk petugas" membuka halaman masuk.

Model akses

- Satu akun = satu orang. **Profil profesi** (nomor SIP, IHS Number praktisi) melekat pada orang, bukan pada jenis akun.
- **Jenis akun** adalah paket izin siap pakai yang dinamis: klinik bebas membuat, mengubah, dan menonaktifkan. Satu akun boleh memiliki beberapa jenis sekaligus dengan periode mulai/selesai (cocok untuk rotasi).
- **Izin tambahan atau pengurangan per akun** oleh pimpinan, lengkap dengan alasan dan periode.

- Izin = fitur × aksi (input, perbaikan, lihat) × cakupan. Akses efektif = gabungan jenis aktif + tambahan − pengurangan.
- Akun tidak dihapus permanen; "hapus" berarti nonaktif dan penugasan diberi tanggal selesai.

Jenis akun paket awal

Jenis akun	Fungsi utama
Admin vendor	Membuat tenant, kredensial SATUSEHAT, status registrasi sistem; tidak membaca isi rekam medis
Pimpinan fasyankes	Menetapkan hak akses dan SOP, menyetujui perbaikan data setelah 2x24 jam, menerima permintaan pembukaan rekam medis
Dokter/DPJP	Anamnesis, diagnosis, tindakan, resep, resume medis, persetujuan tindakan
Perawat/Bidan/Nakes lain	Skrining, tanda vital, asesmen, catatan harian rawat inap
Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	Registrasi, pengkodean ICD, pelaporan, perbaikan data, pembukaan dan penyampaian rekam medis
Petugas pendaftaran	Registrasi pasien, general consent, data sosial
Petugas klaim/kasir	Pembayaran, shift kasir, klaim JKN (SEP, FPK, rekap), batas 6 bulan
Apoteker/tenaga kefarmasian	Telaah resep, penyiapan dan serah terima obat, stok
Analis lab	Spesimen, hasil lab, validasi
Admin IT fasyankes	Integrasi SATUSEHAT, master data, pantau antrean kirim
Petugas PDP (PPDP)	Hak pasien, ROPA, DPIA, insiden, retensi
Auditor	Hanya melihat log dan laporan

Peringatan izin

Pimpinan boleh memberi izin berisiko dengan mengisi alasan. Contoh yang memicu peringatan: izin klinis ke akun tanpa SIP dokter, pembuat dan penyetuju perbaikan data orang yang sama, izin lihat tanpa batas pasien, admin IT diberi izin lihat rekam medis, penugasan melewati masa berlaku SIP. Semua tercatat di Log audit dan di tab **Daftar peringatan izin**.

> Pada simulasi ini akun uji "yudi" memegang 12 jenis akun sekaligus sehingga semua menu terlihat dan akun itu menampilkan "6 peringatan" di daftar pengguna. Itu wajar untuk pengujian, tetapi sebaiknya tidak dipakai di klinik sungguhan.

3. Peta menu

Halaman	Tab	Fungsi
Daftar pasien (awal)	Antrean pasien · Poli · Praktisi · Jadwal praktik	Cari pasien, antrean semua tahap, titik buka seluruh modal pelayanan
Statistik pelayanan	—	Analisis alur pelayanan: durasi per tahap, penumpukan, pasien dalam proses
Pesan	WhatsApp · Instagram	Percakapan dengan pasien lewat WhatsApp dan Instagram
Rawat inap	Papan bed · Daftar ruang · Daftar bed	Penempatan pasien, admisi, pindah ruang, catatan harian, pemulangan
Penunjang	Rekap lab · Master pemeriksaan	Rekap order lab dan pengelolaan master pemeriksaan
Farmasi	Master obat dan stok · Riwayat obat	Master obat tertaut KFA, harga, stok, mutasi, riwayat
Kasir dan klaim	Shift dan rekap harian · Klaim JKN/BPJS · Tarif layanan	Shift kasir, rekap, penyiapan dan status klaim, tarif

Halaman	Tab	Fungsi
Rekam medis	Berkas pasien · Pengkodean dan laporan · Antrean perbaikan · Resume dan surat · Permintaan pembukaan · Penyampaian	Seluruh pengelolaan berkas rekam medis
SATUSEHAT	—	Integrasi Kemenkes (belum tersedia)
Pelindungan data	Persetujuan dan pemberitahuan · Permintaan hak pasien · ROPA · DPIA · Insiden · Retensi dan pemusnahan · Prosesor	Pengelolaan data pribadi sesuai UU PDP
Log audit	—	Jejak semua tindakan akun
Akses dan keamanan	Pengguna dan akses · Jenis akun · Daftar peringatan izin · Keamanan	Akun, jenis akun, izin, kebijakan keamanan
Pengaturan klinik	Profil klinik · Backup	Data fasyankes, website publik, cadangan
Beranda tugas	—	Pengganti Daftar pasien untuk akun yang tidak melihat rekam medis

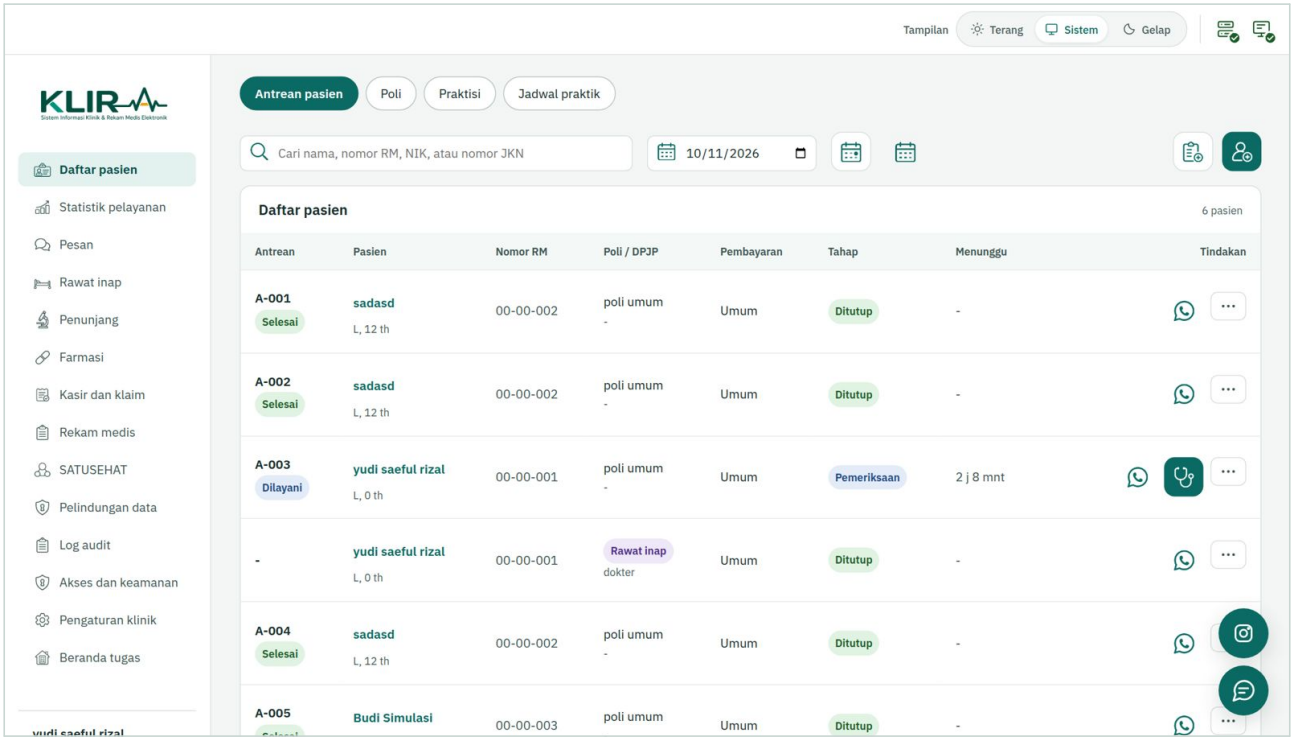
Selain menu, ada dua alamat khusus: **Layar panggilan** (tampilan TV ruang tunggu, tanpa login) dan **website publik** klinik.

4. Fitur per halaman

4.1 Daftar pasien

Halaman awal. Satu tabel untuk seluruh tahap pelayanan (tanpa tab tahap): nomor antrean, pasien, nomor RM, poli/DPJP, pembayaran, tahap, lama menunggu, dan tombol tindakan yang mengikuti izin serta tahap pasien itu.

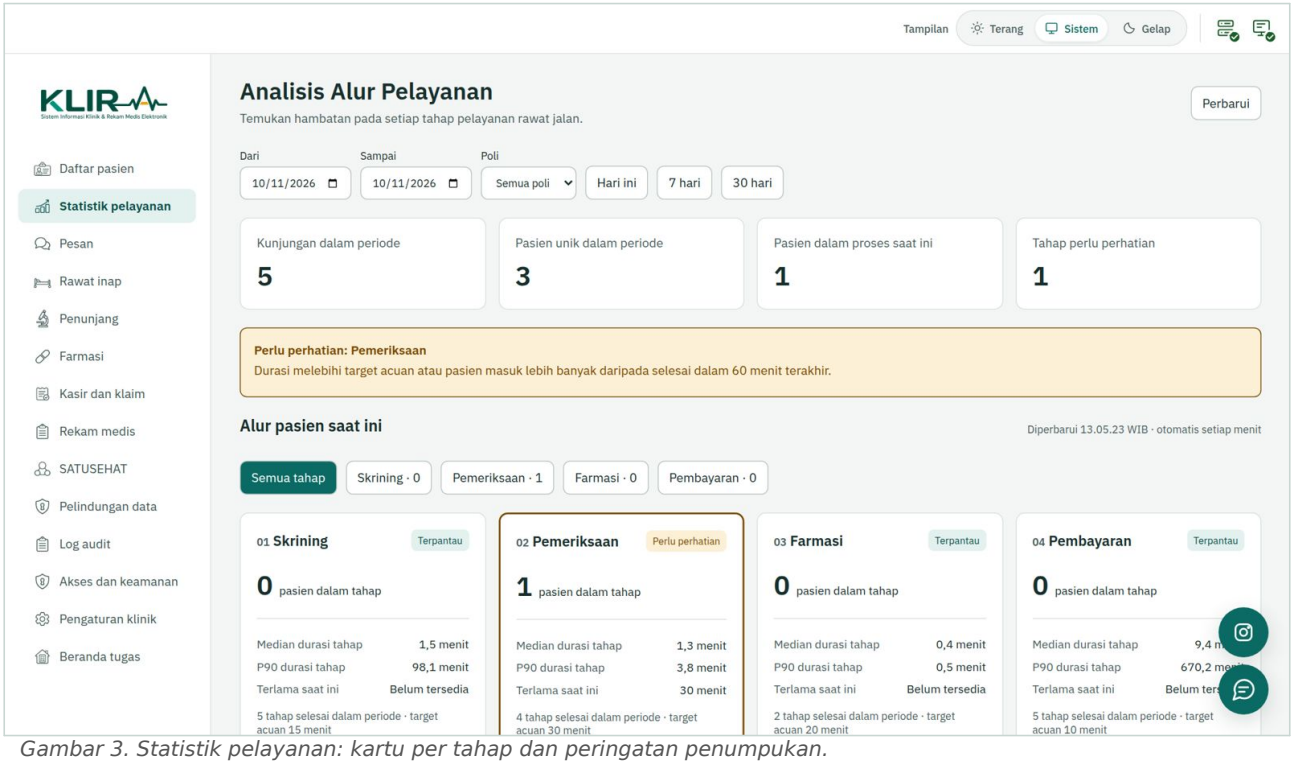
- **Pencarian** nama, nomor RM, NIK, atau nomor JKN; **tanggal kunjungan** dengan tombol Hari ini / Kemarin.
- Dua tombol di kanan atas: **Daftarkan kunjungan** dan **Registrasi pasien baru**.
- Tombol per baris berubah sesuai tahap: Panggil · Skrining · Periksa · Telaah resep · Serahkan obat · Pembayaran · Tutup kunjungan; menu "…" berisi Batalkan, Buka data, Riwayat, Keluarga.
- Ikon WhatsApp membuka percakapan dengan pasien; daftar hanya menampilkan data minimal, isi rekam medis terbuka saat pasien dipilih dan tercatat di audit.
- Tab lain: **Poli**, **Praktisi**, **Jadwal praktik** (master yang memengaruhi layanan di website publik).



Gambar 2. Daftar pasien (data uji). Status berubah otomatis mengikuti pelayanan: Menunggu → Dilayani → Selesai → Ditutup.

4.2 Statistik pelayanan

Analisis alur pelayanan per periode dan poli: jumlah kunjungan, pasien dalam proses, tahap yang perlu perhatian, kartu per tahap (Skrining, Pemeriksaan, Farmasi, Pembayaran) dengan rata-rata durasi, serta grafik penumpukan per tahap.

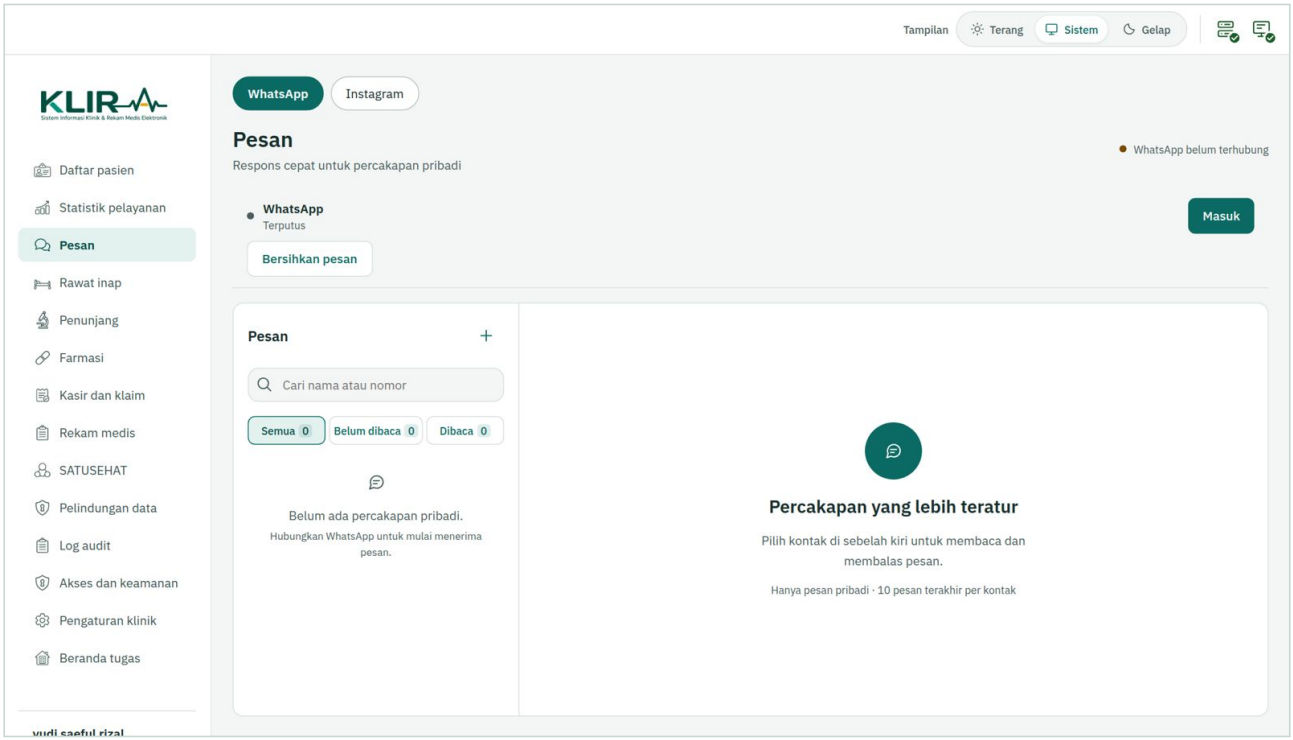


Gambar 3. Statistik pelayanan: kartu per tahap dan peringatan penumpukan.

4.3 Pesan

Dua tab: WhatsApp dan Instagram. Percakapan masuk dari pasien, penanda belum dibaca, dan ikon pintasan di pojok kanan bawah semua halaman. Perlu koneksi WhatsApp/Instagram yang

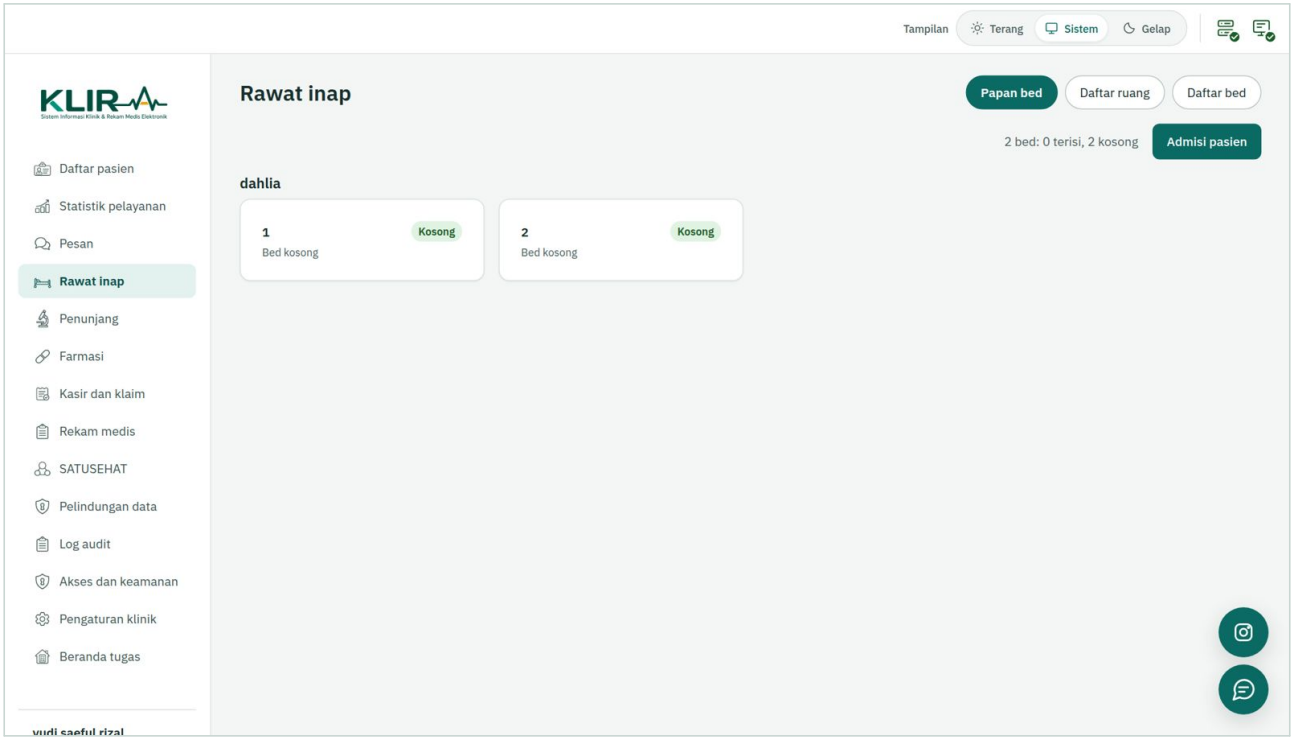
dikonfigurasi lewat .env.



Gambar 4. Halaman Pesan.

4.4 Rawat inap

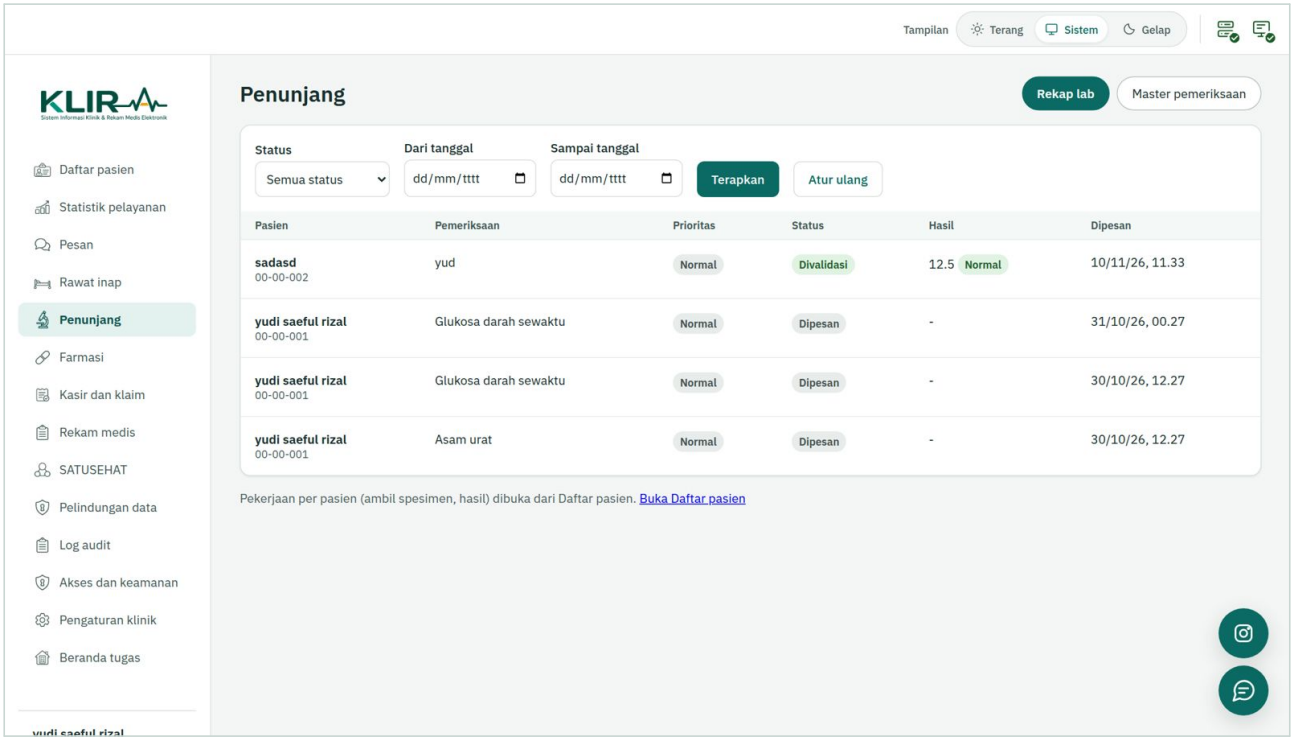
Papan bed memperlihatkan bed dan pasien, **Daftar ruang** dan **Daftar bed** adalah master. Tombol aksi: Admisi pasien, Ubah penempatan, Catatan harian (CPPT), Pemulangan.



Gambar 5. Papan bed rawat inap.

4.5 Penunjang (laboratorium)

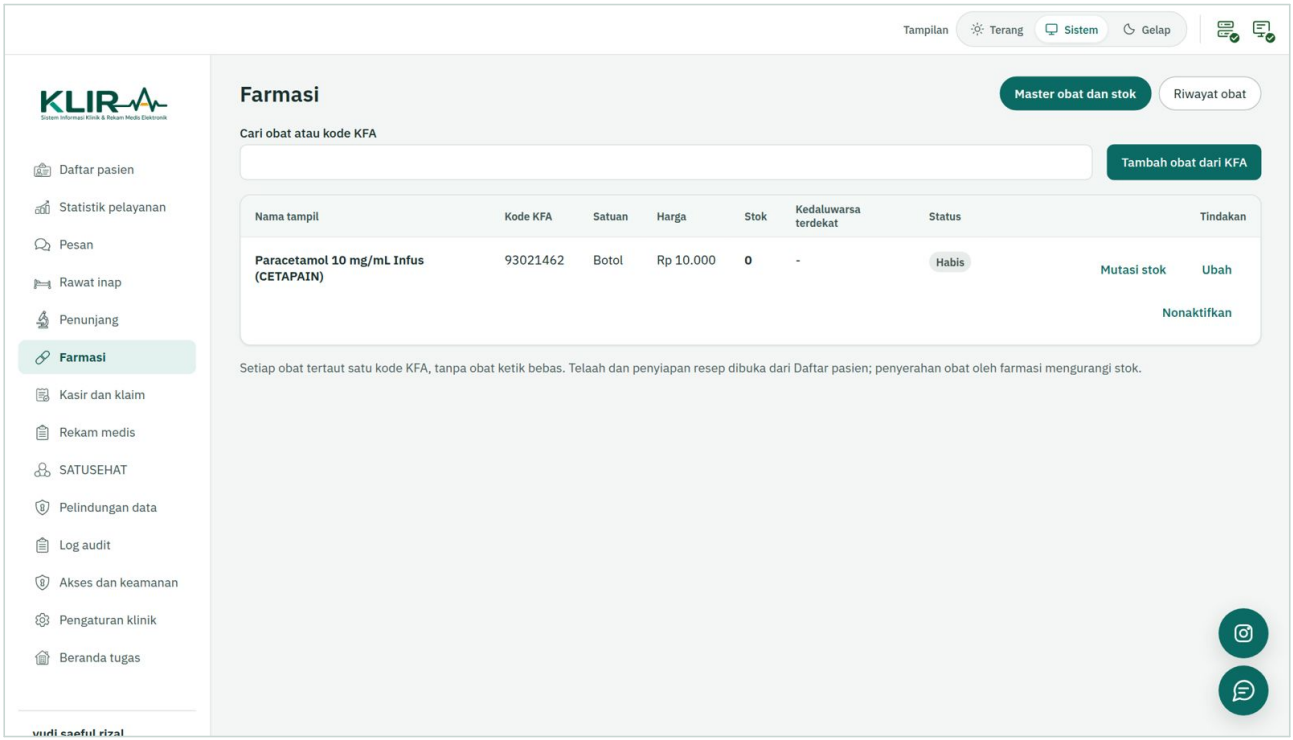
Rekap lab menampilkan order dan statusnya (dipesan, spesimen diambil, hasil, validasi). **Master pemeriksaan** mengelola daftar pemeriksaan (terhubung LOINC). Order dibuat dari langkah P — Plan di pemeriksaan klinis; pengambilan spesimen dan hasil dikerjakan dari Daftar pasien.



Gambar 6. Rekap lab.

4.6 Farmasi

Master obat dan stok: pilih obat dari katalog KFA, atur satuan, harga, dan aktif/nonaktif; **Mutasi stok** untuk terima, keluar, koreksi (batch, kedaluwarsa, jumlah, alasan). **Riwayat obat** menampilkan pengeluaran. Perubahan harga tercatat sebagai audit.

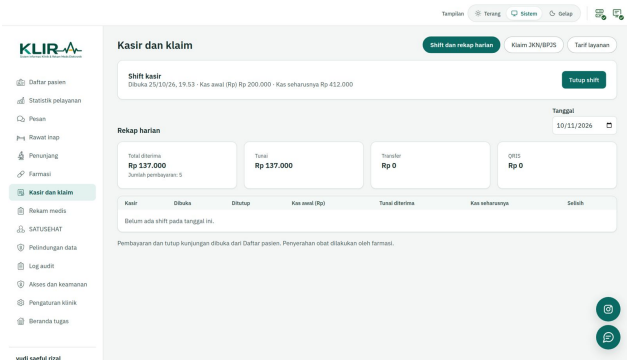


Gambar 7. Master obat dan stok. Tombol "Master obat dari KFA", "Tambahkan dari KFA", "Ubah", dan "Mutasi stok".

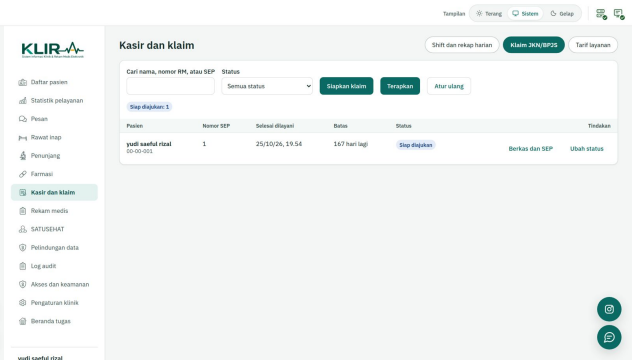
4.7 Kasir dan klaim

- **Shift dan rekap harian**: buka/tutup shift (kas awal, kas akhir, selisih dan alasan).
- **Klaim JKN/BPJS**: kunjungan siap klaim, nomor SEP, berkas klaim, batas 6 bulan, status (siap diajukan, dikembalikan, diajukan ulang, dibayar).

- **Tarif layanan**: master tarif.
- Pembayaran, serah terima obat, dan tutup kunjungan per pasien dibuka dari Daftar pasien.



Gambar 8a. Shift dan rekap harian.

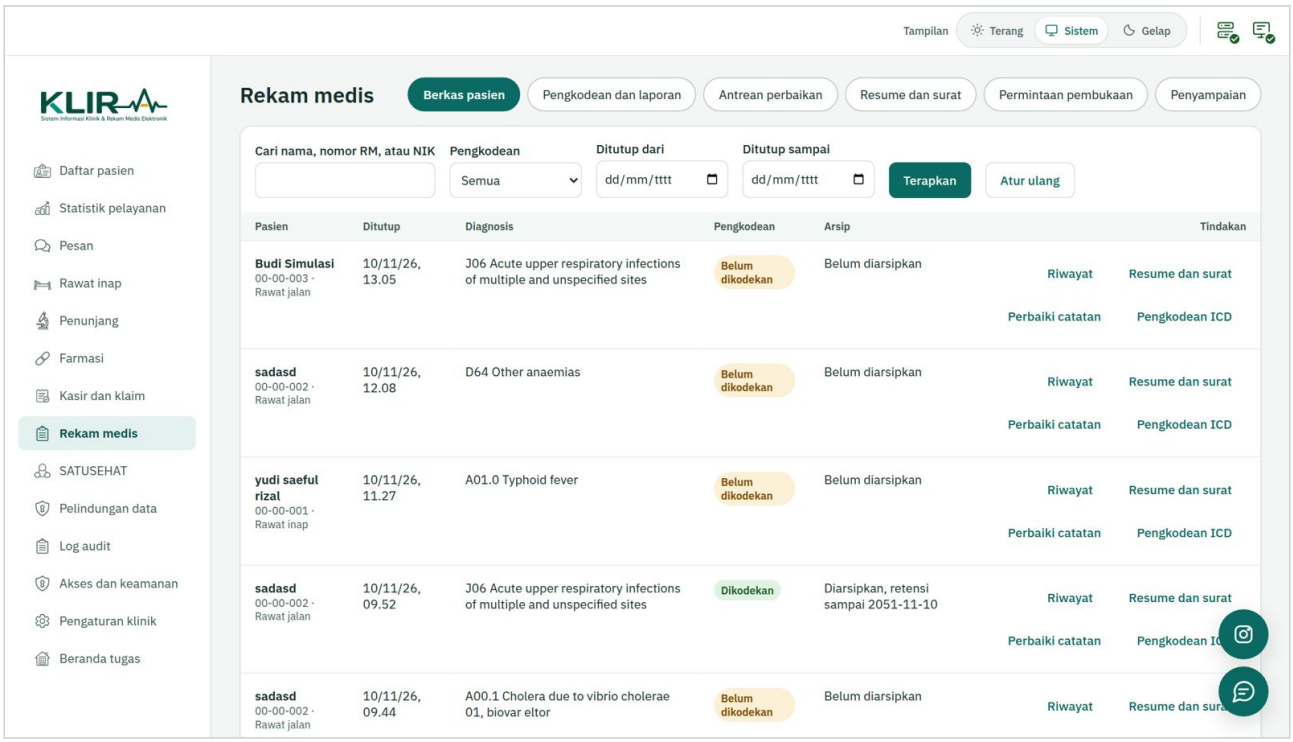


Gambar 8b. Klaim JKN/BPJS.

4.8 Rekam medis

Pusat pengelolaan berkas. Setiap baris: pasien, tanggal tutup, diagnosis, status pengkodean, status arsip, dan tindakan (Riwayat, Resume dan surat, Perbaiki catatan, Pengkodean ICD).

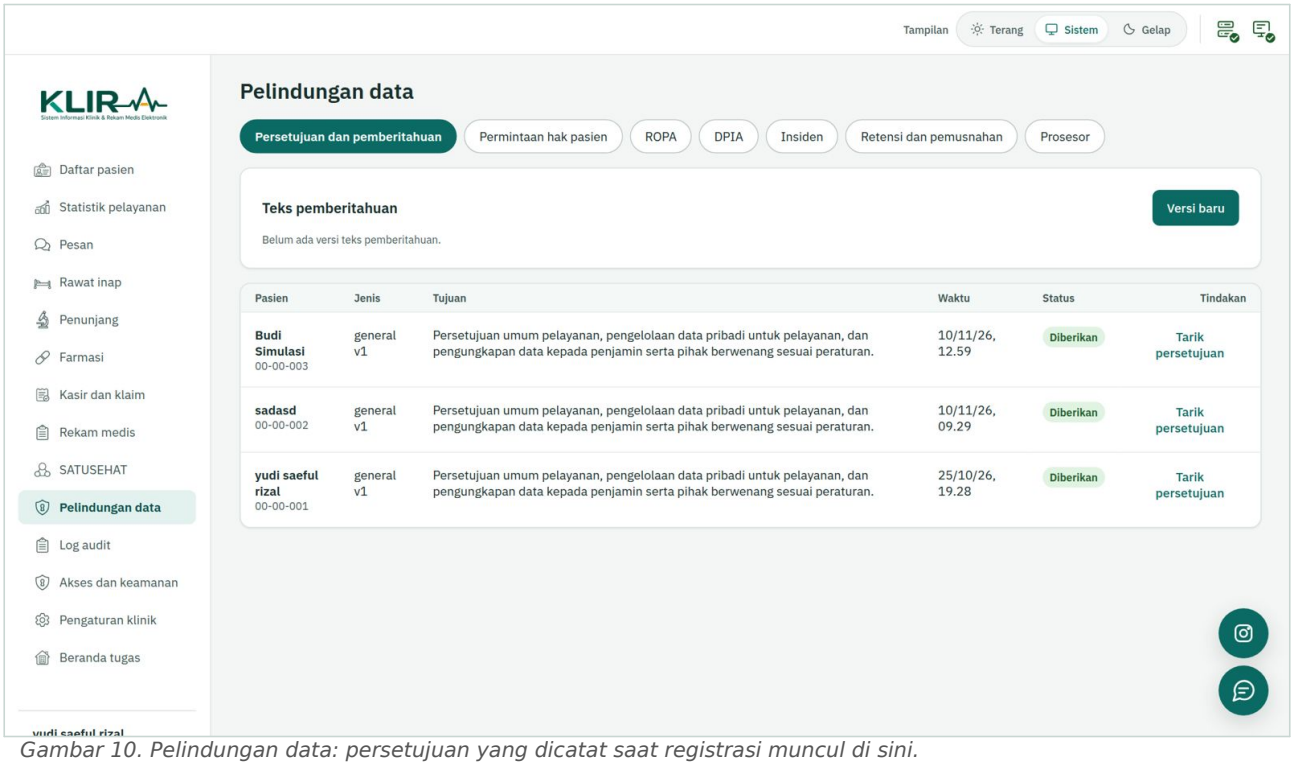
Tab	Fungsi
Berkas pasien	Daftar kronologis, versi perbaikan, pengesahan; filter status kode dan tanggal tutup
Pengkodean dan laporan	Kode ICD-10/ICD-9 CM final dan pembuatan laporan
Antrean perbaikan	Permintaan perbaikan catatan (2x24 jam) untuk ditinjau pimpinan
Resume dan surat	Resume medis, surat rujukan, SPRI
Permintaan pembukaan	Pembukaan rekam medis oleh pihak berwenang dengan dasar, cakupan, identitas disamarkan
Penyampaian	Penyampaian rekam medis ke pasien/wali/pihak lain dengan persetujuan



Gambar 9. Rekam medis, tab Berkas pasien. Kunjungan yang sudah dikodekan otomatis diarsipkan dengan retensi 25 tahun.

4.9 Pelindungan data

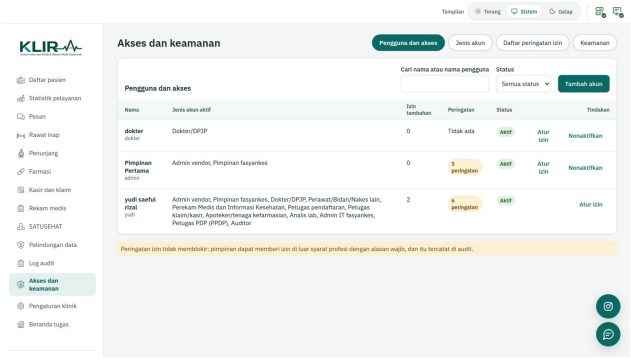
Tujuh tab: teks pemberitahuan berversi dan daftar persetujuan (dengan tombol *Tarik persetujuan*); permintaan hak pasien (tenggat 3x24 jam); ROPA; DPIA; insiden kebocoran (notifikasi 3x24 jam); retensi dan pemusnahan (berita acara); prosesor (perjanjian, sub-prosesor, SLA).



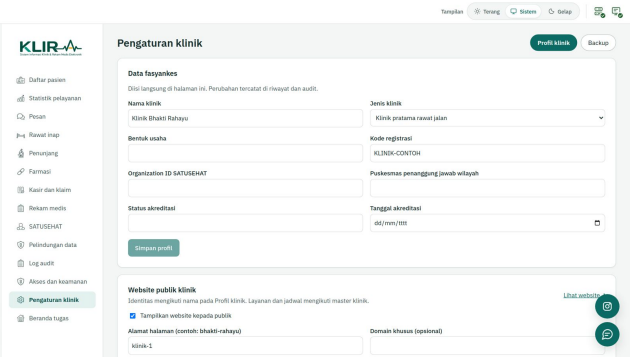
Gambar 10. Pelindungan data: persetujuan yang dicatat saat registrasi muncul di sini.

4.10 Log audit, Akses dan keamanan, Pengaturan klinik

- **Log audit**: jejak tindakan akun (login, buka data, simpan, perubahan harga, peringatan yang diterima).
- **Akses dan keamanan**: kelola pengguna (tambah akun, atur izin, nonaktifkan), jenis akun, daftar peringatan izin, kebijakan keamanan.
- **Pengaturan klinik**: profil klinik (nama, jenis, kode registrasi, akreditasi), pengaturan **website publik** (slug, domain, warna, jam operasional, kontak), dan **Backup**.



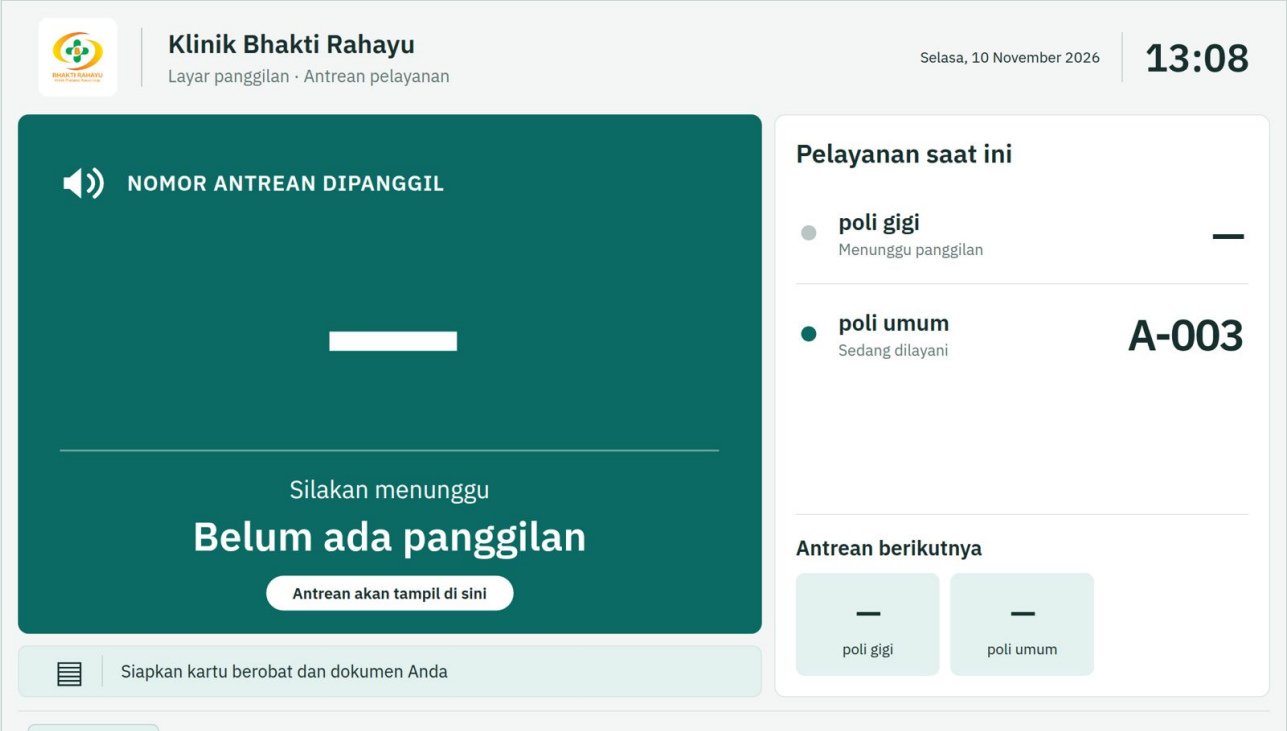
Gambar 11a. Pengguna dan akses.



Gambar 11b. Profil klinik dan website publik.

4.11 Beranda tugas dan Layar panggilan

- **Beranda tugas**: halaman awal akun yang tidak membaca rekam medis (admin IT, admin vendor, petugas PDP): tugas, status kirim, permintaan hak.
- **Layar panggilan** (`/layar-panggilan/ID-fasilitas`): tampilan TV ruang tunggu tanpa login; panggilan terbaru, antrean per poli, suara bahasa Indonesia (klik "Aktifkan suara" sekali), dan pulih otomatis bila koneksi terputus.



Gambar 12. Layar panggilan publik.

5. Hasil simulasi rawat jalan: Budi Simulasi

Simulasi dijalankan 10 November 2026 pada server Klira di database pengembangan `klira_dev` memakai akun uji **yudi** (merangkap semua jenis akun). Satu pasien fiktif dibawa melalui seluruh alur rawat jalan lewat antarmuka web, sambil mengambil tangkapan layar tiap langkah.

Data uji	Nilai
Pasien	Budi Simulasi, laki-laki, lahir 15-01-1990, NIK fiktif 3201011501900009, ibu kandung Siti Simulasi
Alamat	Ciomas Rahayu, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Poli / pembayaran	Poli umum · Umum (non-JKN)
Keluhan	Demam dan batuk sejak 3 hari
Diagnosis	J06 — Infeksi saluran napas akut atas
Hasil	Nomor RM 00-00-003 · antrean A-005 · resep R-20261110-002 · tagihan Rp 100.000 lunas tunai · kunjungan ditutup · terkode dan diarsipkan

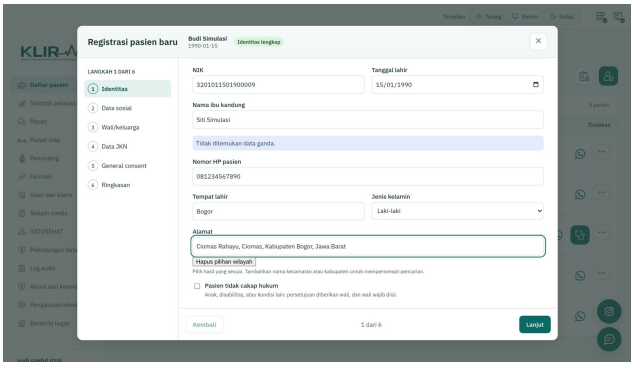
Jejak data. Simulasi ini menulis data sungguhan ke klira_dev: 1 pasien, 1 kunjungan, 1 resep, 1 pembayaran Rp 100.000, serah terima obat (stok Paracetamol infus dikurangi 10 botol dengan persetujuan "stok kurang"), kode ICD final, dan arsip. Semuanya bertanda nama "Budi Simulasi".

Langkah 1 — Registrasi pasien baru (6 langkah)

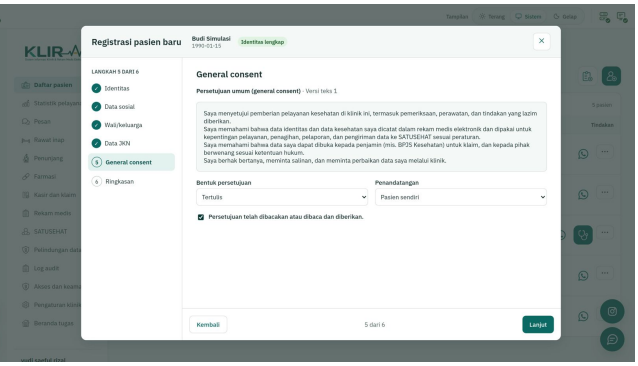
Dari Daftar pasien klik tombol **Registrasi pasien baru** (ikon orang + di kanan atas). Modal bertahap: Identitas → Data sosial → Wali/keluarga → Data JKN → General consent → Ringkasan.

1. **Identitas**: nama lengkap, NIK, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP, tempat lahir, jenis kelamin. Aplikasi mencari duplikat otomatis ("Tidak ditemukan data ganda").
2. **Alamat** adalah pencarian wilayah: ketik nama kelurahan/kecamatan lalu **pilih salah satu hasil** (tidak cukup mengetik bebas — lihat bagian 8). Centang "Pasien tidak cakap hukum" bila perlu wali.
3. **Data sosial**, **Wali/keluarga**, dan **Data JKN** (nomor kartu, kelas hak, FKTP) bersifat opsional; langkah bisa dilompati.

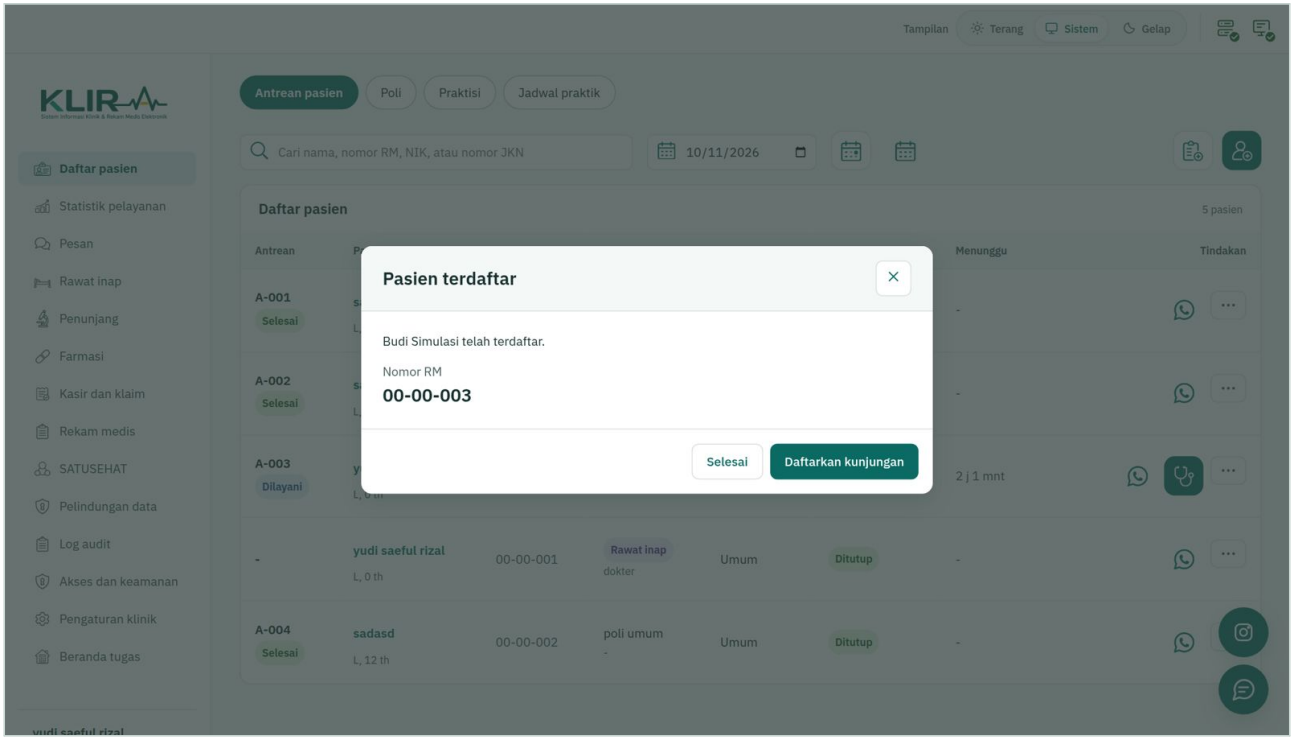
4. **General consent**: pilih bentuk (Tertulis/Lisan), penandatangan (pasien sendiri/wali), centang pernyataan telah dibacakan.
5. **Ringkasan → Daftarkan pasien**.



Gambar 13a. Langkah 1 Identitas; alamat dipilih dari hasil pencarian wilayah.



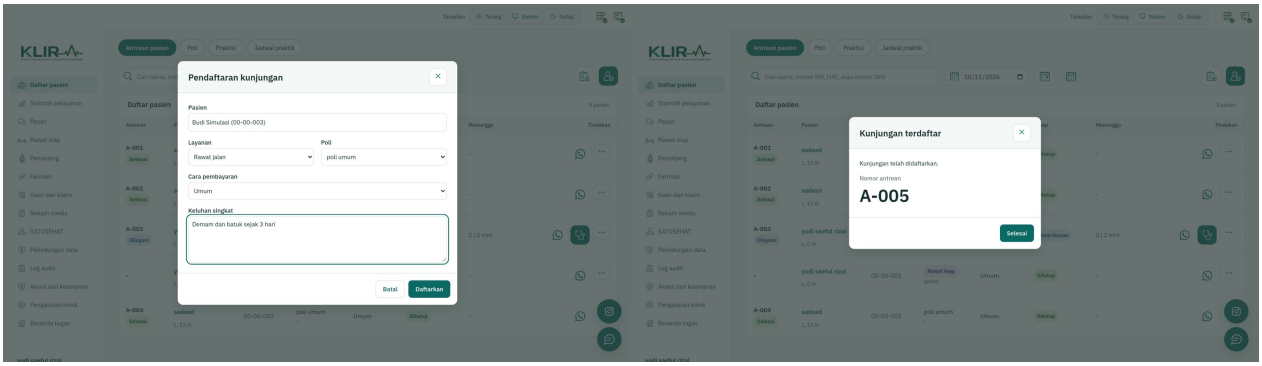
Gambar 13b. Langkah 5 General consent.



Gambar 14. Hasil: "Pasien terdaftar", nomor RM 00-00-003. Tombol langsung ke Daftarkan kunjungan.

Langkah 2 — Pendaftaran kunjungan

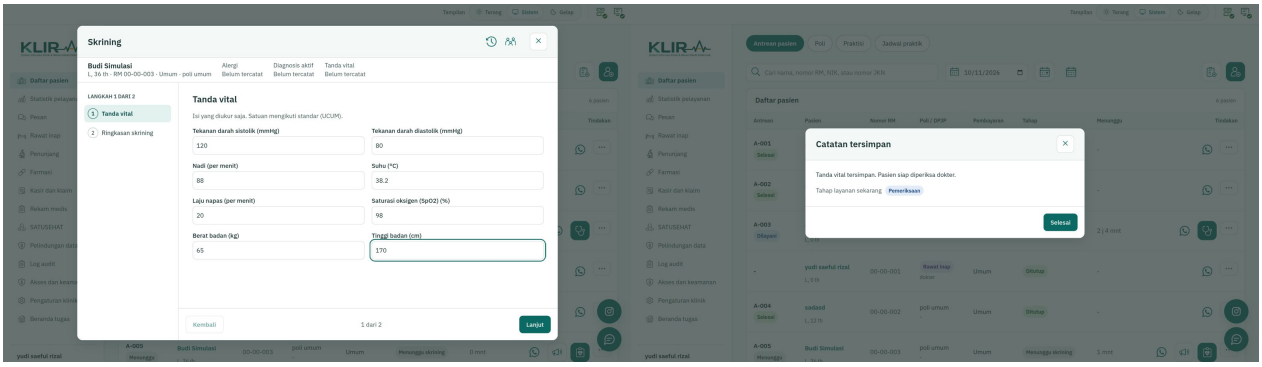
1. Klik **Daftarkan kunjungan** (ikon papan di kanan atas Daftar pasien).
2. Ketik minimal 2 karakter nama pasien lalu pilih dari hasil. Pilih **Layanan** (Rawat jalan / Rawat inap langsung), **Poli**, **Cara pembayaran** (Umum/JKN), dan **Keluhan singkat**.
3. Klik **Daftarkan**. Aplikasi menampilkan nomor antrean.



Gambar 15a. Pendaftaran kunjungan. *Gambar 15b. Hasil: antrean A-005.*

Langkah 3 — Skrining perawat (tanda vital)

Baris pasien berstatus *Menunggu skrining* menampilkan tombol **Skrining**. Isi hanya yang diukur; satuan mengikuti UCUM. Data simulasi: TD 120/80 mmHg, nadi 88, suhu 38,2 °C, napas 20, SpO2 98%, BB 65 kg, TB 170 cm. Lanjut → **Simpan dan sahkan**.



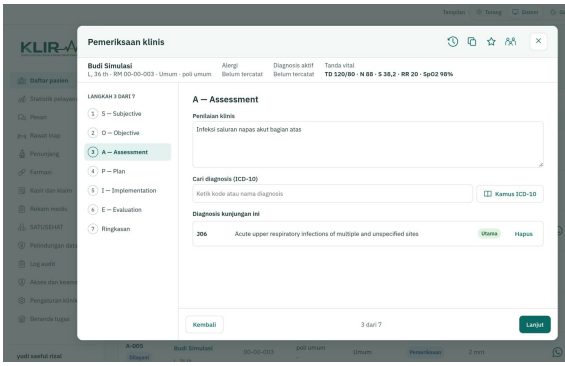
Gambar 16a. Langkah 1 Tanda vital. *Gambar 16b. Setelah disimpan, antrean menjadi Dilayani.*

Menyimpan **draf** atau sekadar membuka formulir belum memulai pelayanan; antrean baru berubah menjadi "Dilayani" setelah catatan pertama disahkan.

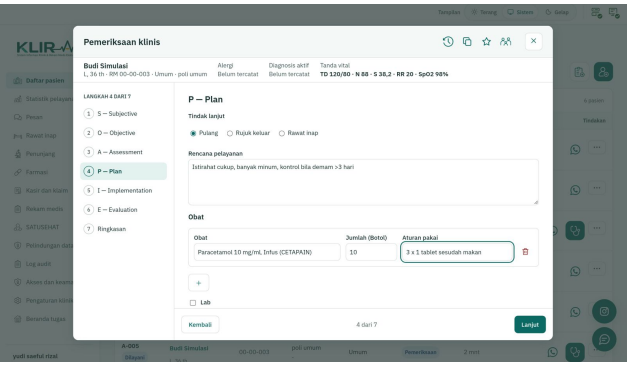
Langkah 4 — Pemeriksaan klinis SOAPIE (7 langkah)

Tombol **Periksa** membuka modal bertahap: S — Subjective, O — Objective, A — Assessment, P — Plan, I — Implementation, E — Evaluation, Ringkasan. Di header ada tombol **Riwayat**, **Salin dari kunjungan sebelumnya**, **Favorit dan templat**, dan **Family folder** sebagai panel samping.

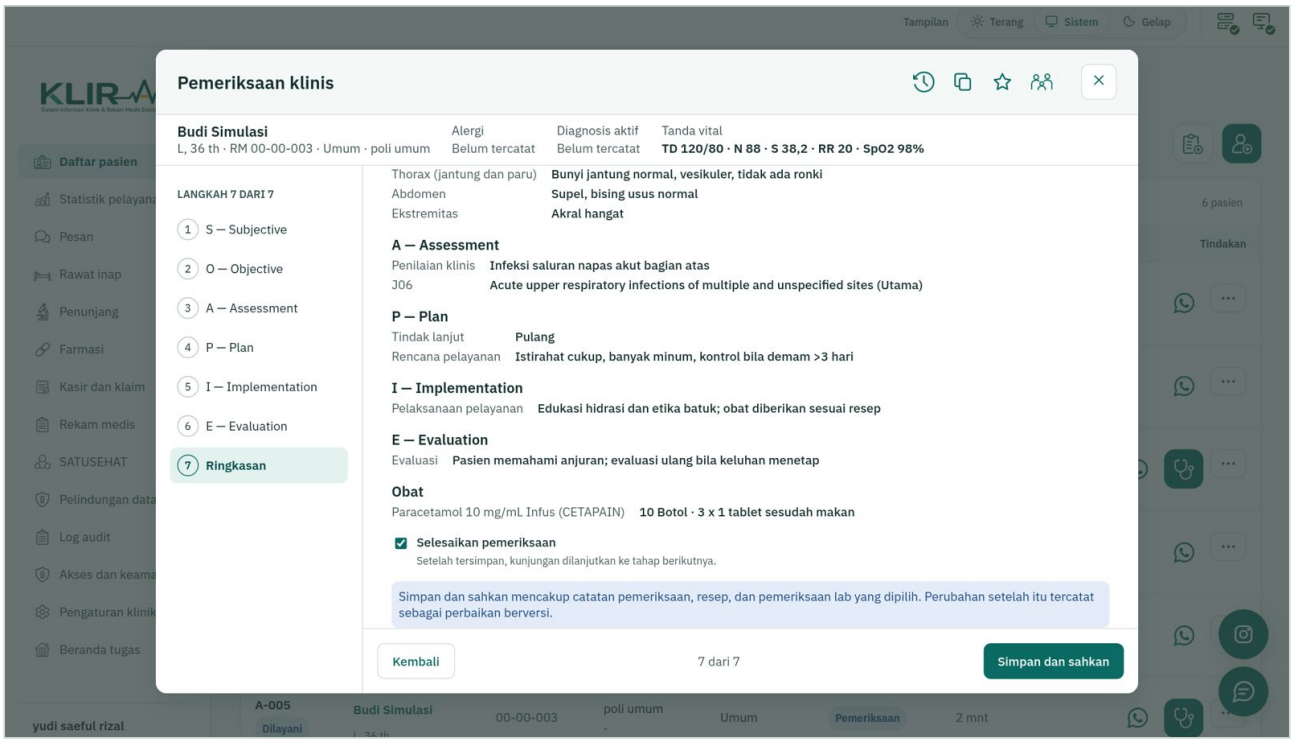
Langkah	Isi yang dikerjakan pada simulasi
S	Keluhan utama dan penyerta, riwayat penyakit pribadi/keluarga, alergi ("Tidak ada" bila tidak ada)
O	Tanda vital (terisi dari skrining) dan pemeriksaan fisik: keadaan umum, kepala-leher, thorax, abdomen, ekstremitas
A	Penilaian klinis; cari diagnosis ICD-10 (ketik "J06" → pilih → ditandai Utama); tombol Kamus ICD-10
P	Tindak lanjut (Pulang / Rujuk keluar / Rawat inap), rencana pelayanan, resep (obat, jumlah, aturan pakai, tambah baris), centang Lab untuk order lab
I	Pelaksanaan pelayanan; cari tindakan ICD-9 CM bila ada tindakan
E	Evaluasi
Ringkasan	Periksa semua bagian, centang "Selesaikan pemeriksaan", lalu **Simpan dan sahkan**



Gambar 17a. A — Assessment dengan diagnosis J06 (Utama).



Gambar 17b. P — Plan: tindak lanjut, rencana, dan resep.

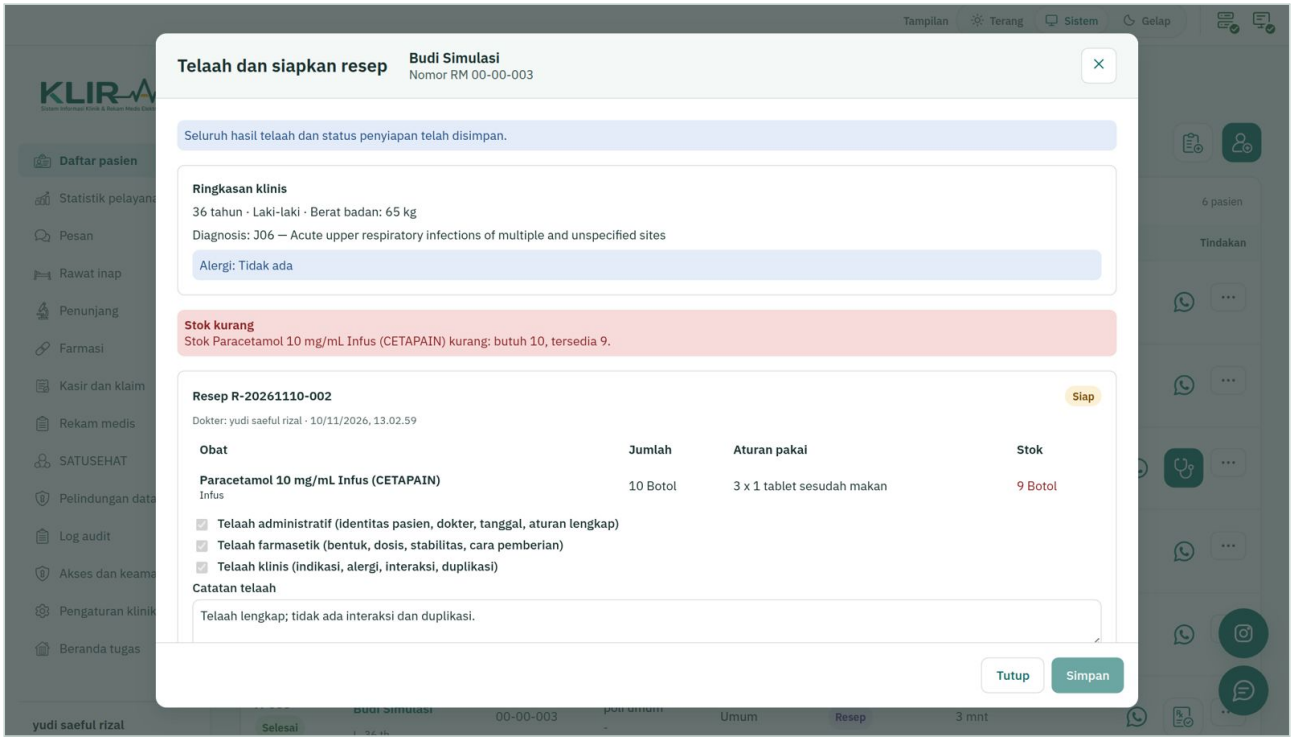


Gambar 18. Ringkasan pemeriksaan: "Simpan dan sahkan" mencakup catatan, resep, dan order lab terpilih. Perubahan setelahnya tercatat sebagai perbaikan berversi.

Resep dan order lab tidak punya tombol terpisah: keduanya terkirim lewat **Simpan dan sahkan** yang sama. Bila pengiriman lab gagal, pilihan dipertahankan; bila resep gagal, drafnya tetap ada.

Langkah 5 — Telaah dan siapkan resep (apoteker)

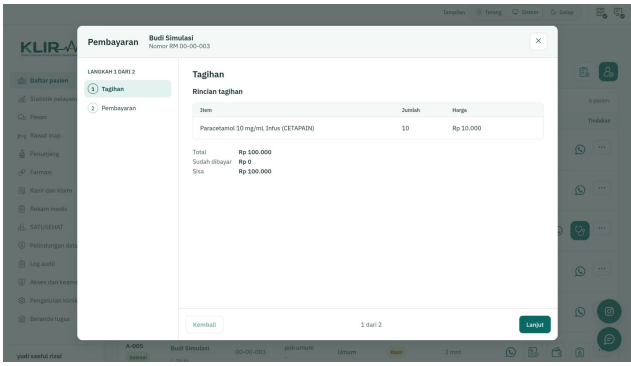
Setelah pemeriksaan, tahap pasien menjadi *Resep* dengan tombol **Telaah resep**. Modal menampilkan ringkasan klinis (umur, berat, diagnosis, alergi), daftar obat dengan stok, tiga telaah (administratif, farmasetik, klinis), catatan, dan kotak **Obat selesai disiapkan**. Klik **Simpan**; resep berubah menjadi **Siap**.



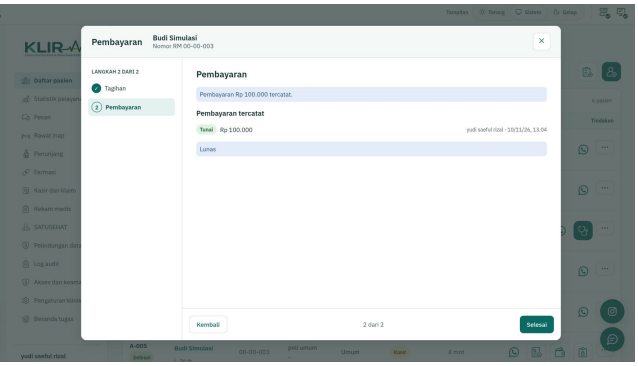
Gambar 19. Telaah resep selesai (status Siap). Banner merah "Stok kurang: butuh 10, tersedia 9" muncul karena stok tercatat lebih sedikit dari permintaan.

Langkah 6 — Pembayaran (kasir, 2 langkah)

1. Tombol **Pembayaran**: langkah **Tagihan** menampilkan rincian (Paracetamol 10 × Rp 10.000 = Rp 100.000), total, sudah dibayar, sisa.
2. Langkah **Pembayaran**: pilih metode (Tunai/Transfer/QRIS), isi jumlah diterima, klik **Catat pembayaran**. Status berubah **Lunas**.



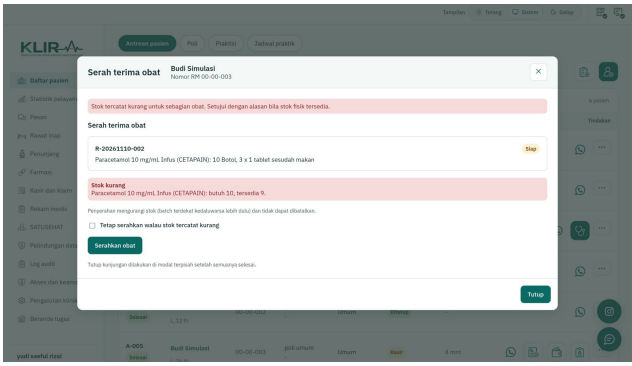
Gambar 20a. Tagihan.



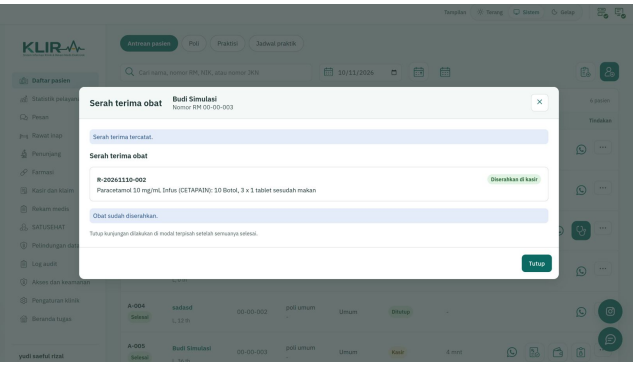
Gambar 20b. Pembayaran Rp 100.000 tercatat, Lunas.

Langkah 7 — Serah terima obat

Tombol **Serahkan obat**. Penyerahan mengurangi stok (batch yang terdekat kedaluwarsa lebih dulu) dan **tidak dapat dibatalkan**. Karena stok tercatat kurang, aplikasi menolak penyerahan biasa dan meminta persetujuan: centang **Tetap serahkan walau stok tercatat kurang** dan isi **Alasan** (simulasi: "stok fisik tersedia, selisih pencatatan 1 botol"). Alasan ini tercatat di audit.



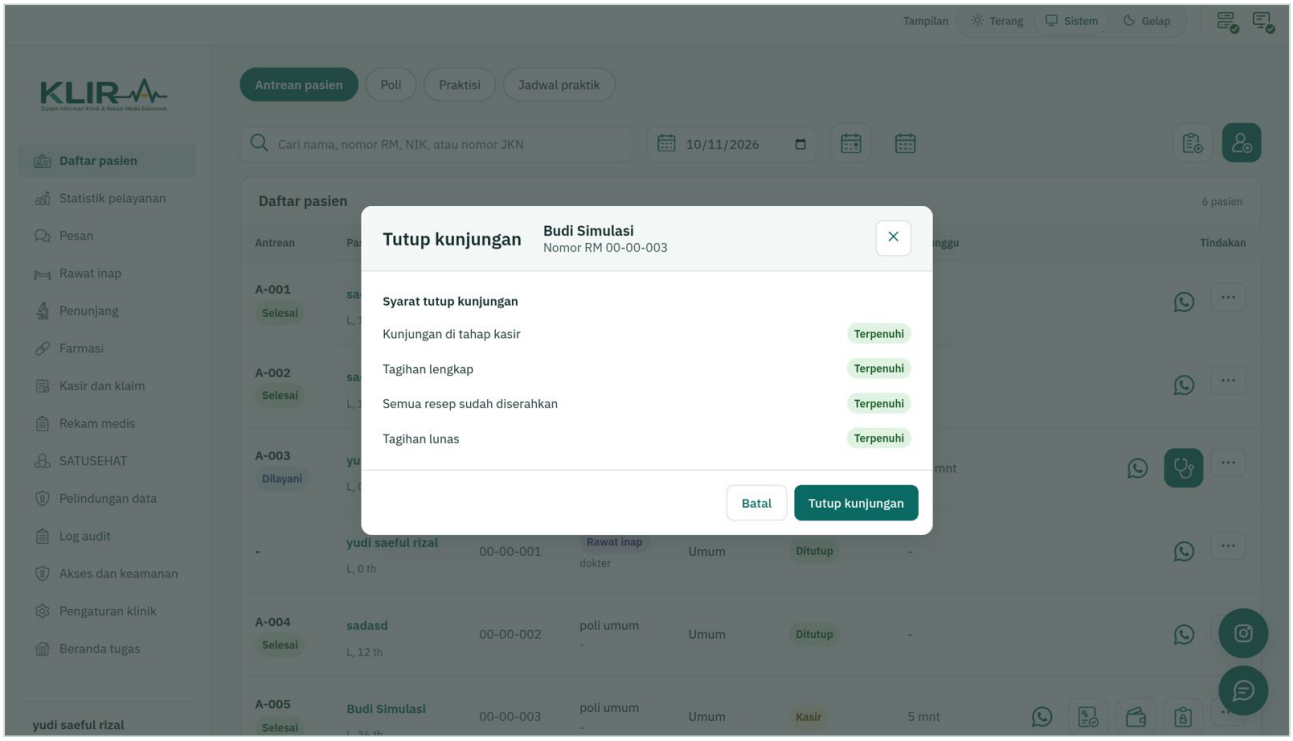
Gambar 21a. Peringatan stok kurang.



Gambar 21b. "Serah terima tercatat. Obat sudah diserahkan."

Langkah 8 — Tutup kunjungan

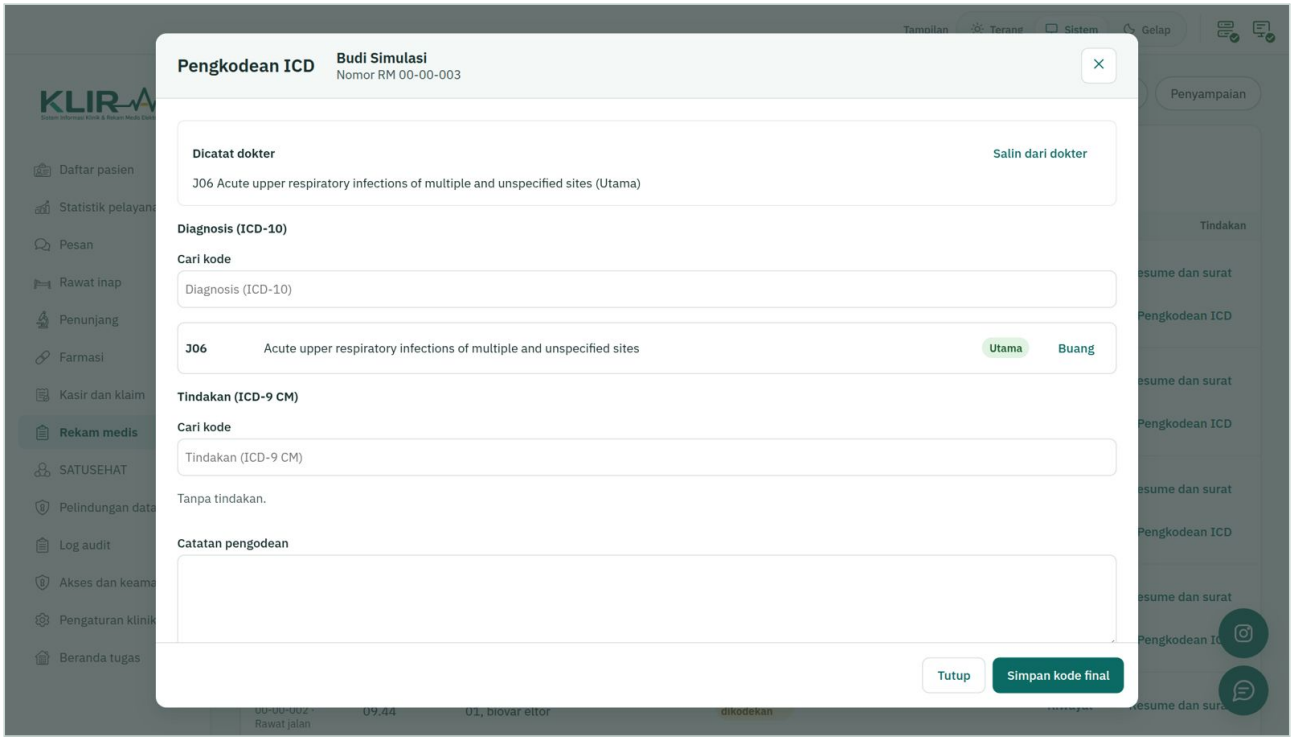
Tombol **Tutup kunjungan** memeriksa empat syarat: kunjungan di tahap kasir, tagihan lengkap, semua resep diserahkan, tagihan lunas. Bila ada yang belum, muncul peringatan dengan alasan wajib. Klik **Tutup kunjungan**; status menjadi **Ditutup** dan antrean selesai.



Gambar 22. Semua syarat penutupan "Terpenuhi".

Langkah 9 — Pengkodean ICD (perekam medis)

Di **Rekam medis → Berkas pasien**, kunjungan yang baru ditutup berstatus *Belum dikodekan*. Klik **Pengkodean ICD**: aplikasi menampilkan kode yang dicatat dokter; tombol **Salin dari dokter** mengisi otomatis, atau cari kode ICD-10 dan ICD-9 CM sendiri. Isi catatan pengodean lalu **Simpan kode final**.

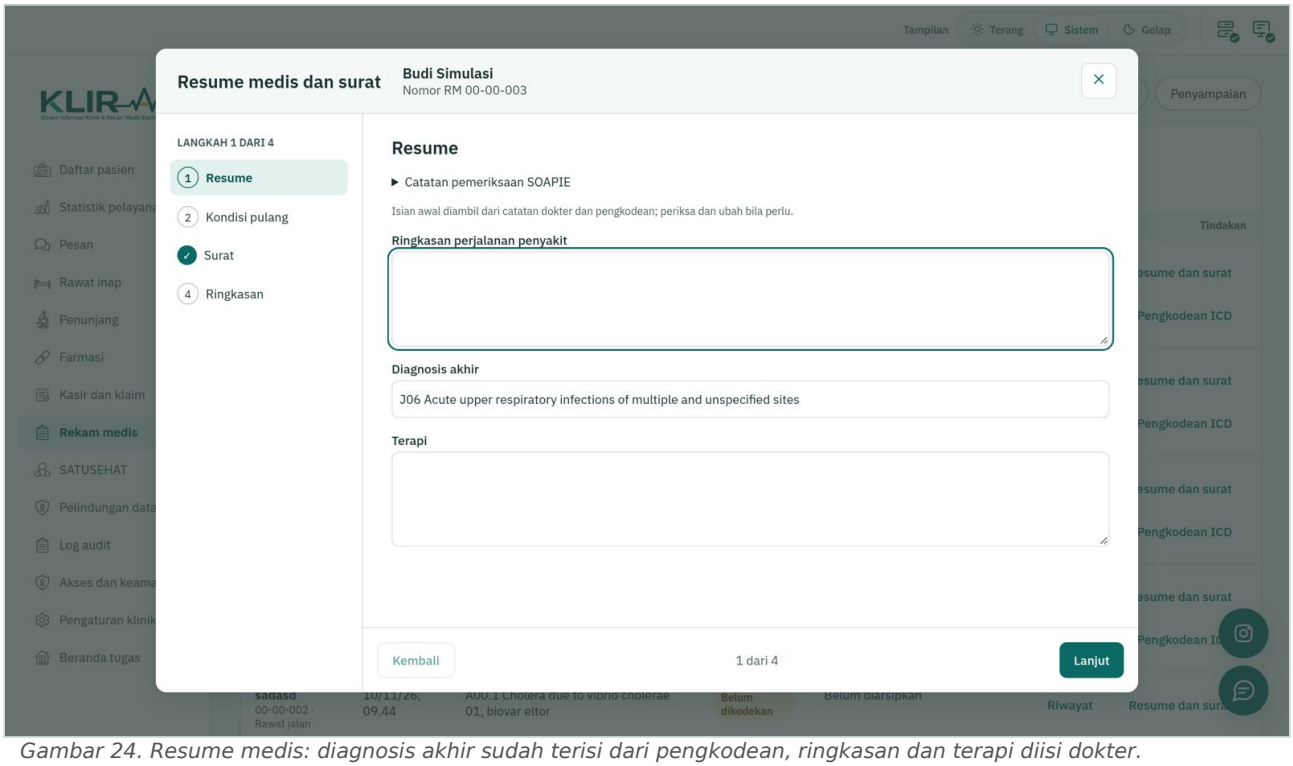


Gambar 23. Pengkodean ICD: J06 sebagai diagnosis utama, tanpa tindakan.

Hasil: status menjadi **Dikodekan** dan berkas otomatis **Diarsipkan, retensi sampai 10-11-2051** (25 tahun sesuai kebijakan rekam medis elektronik).

Langkah 10 — Resume medis dan surat

Tombol **Resume dan surat** membuka modal 4 langkah: Resume → Kondisi pulang → Surat → Ringkasan. Isian awal diambil dari catatan dokter dan pengkodean; periksa dan ubah bila perlu. Di sini dibuat ringkasan perjalanan penyakit, diagnosis akhir, terapi, dan surat rujukan bila diperlukan.



Gambar 24. Resume medis: diagnosis akhir sudah terisi dari pengkodean, ringkasan dan terapi diisi dokter.

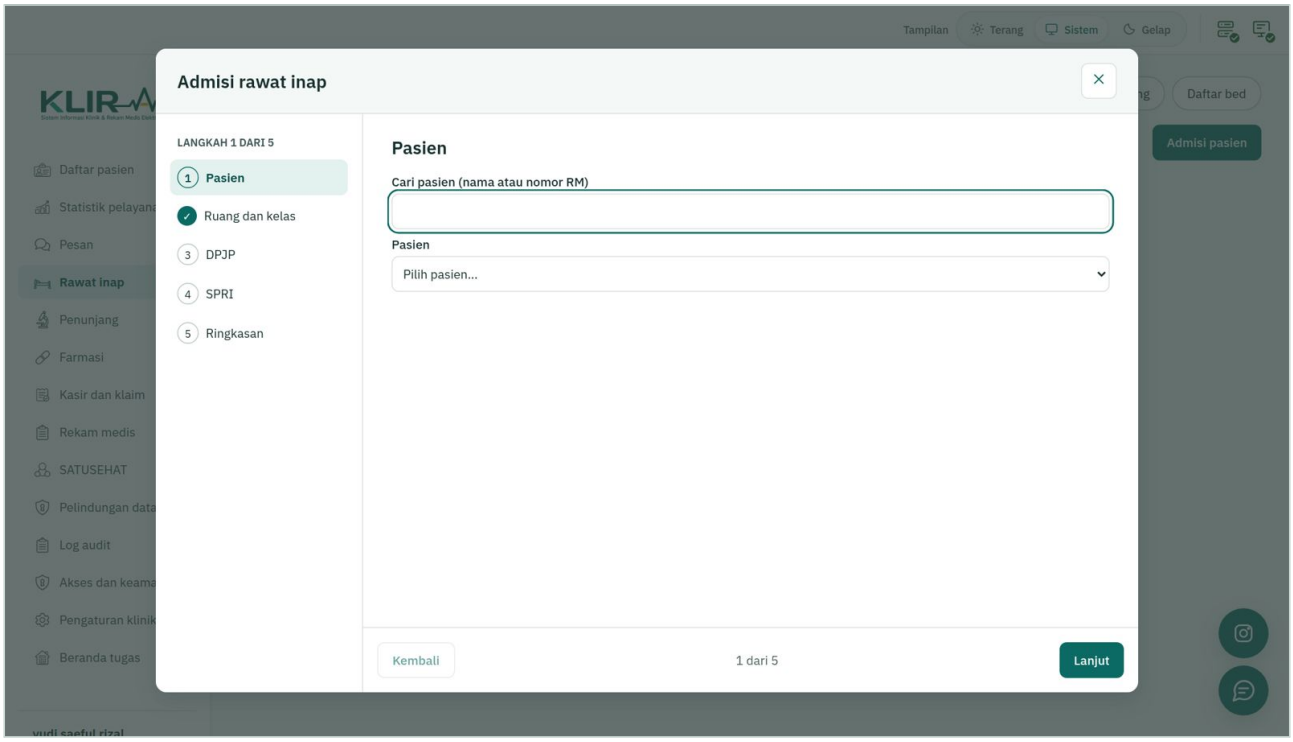
> Langkah 10 pada simulasi hanya dibuka dan dilihat, tidak disimpan.

6. Tutorial tugas lain

Bagian ini memakai tangkapan layar modal yang dibuka tanpa menyimpan data. Alur diambil dari langkah yang tampil di layar dan rancangan aplikasi.

6.1 Admisi rawat inap

Rawat inap → Admisi pasien. Modal 5 langkah: Pasien → Ruang/bed dan kelas → DPJP → SPRI → Ringkasan. Dari rawat jalan, pilih tindak lanjut *Rawat inap* di P — Plan: kunjungan asal ditutup dan tagihan digabung. Setelah itu: **Ubah penempatan** (pindah ruang/kelas/DPJP bersama), **Catatan harian (CPPT)** (catatan, tanda vital, pemberian obat), dan **Pemulangan rawat inap** (ringkasan → diagnosis akhir → kondisi pulang → tindak lanjut → resume).



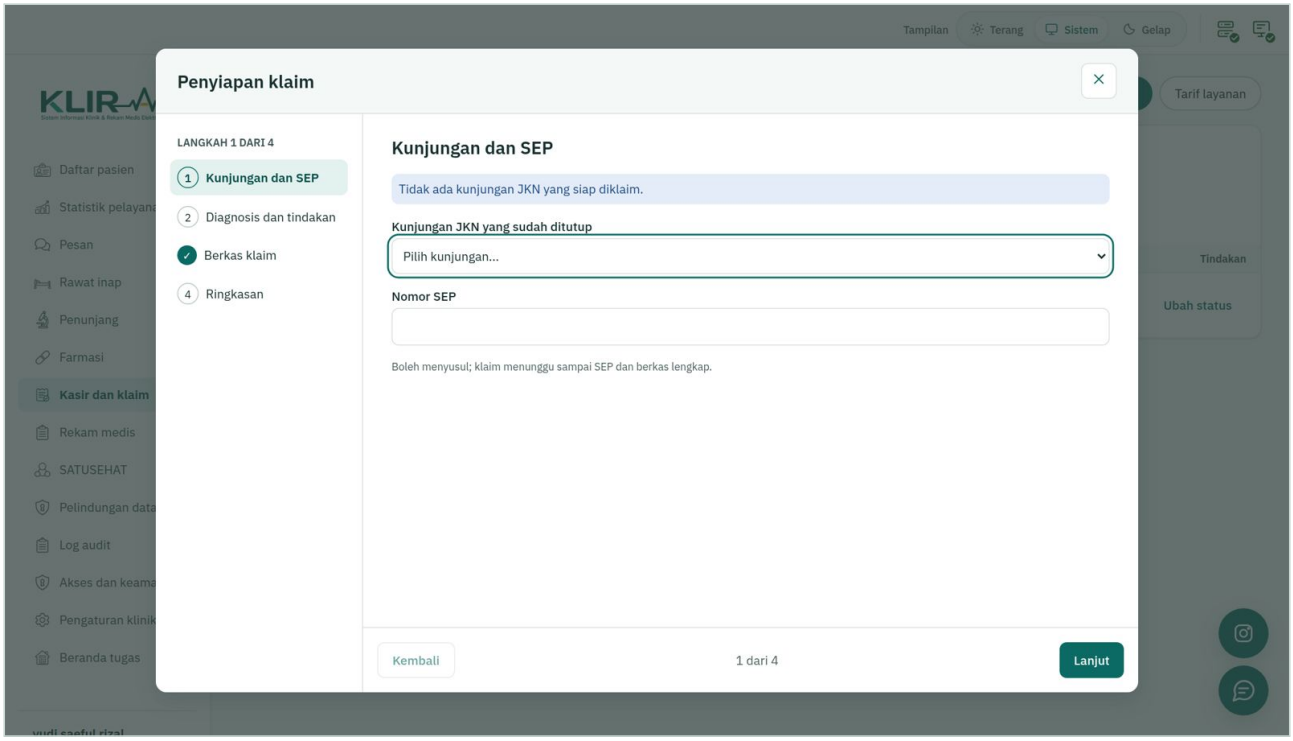
Gambar 25. Admisi rawat inap.

6.2 Order lab, spesimen, dan hasil

1. Di **P — Plan** pemeriksaan klinis, centang **Lab**, cari pemeriksaan, tentukan prioritas dan catatan. Order terkirim saat Simpan dan sahkan.
2. Analis lab membuka **Ambil spesimen** dari Daftar pasien (spesimen, waktu, petugas).
3. **Hasil lab**: modal 3 langkah Hasil → Interpretasi → Validasi. Rekap tampil di **Penunjang → Rekap lab**; pemeriksaan yang ditagih ikut ke tagihan.

6.3 Klaim JKN/BPJS

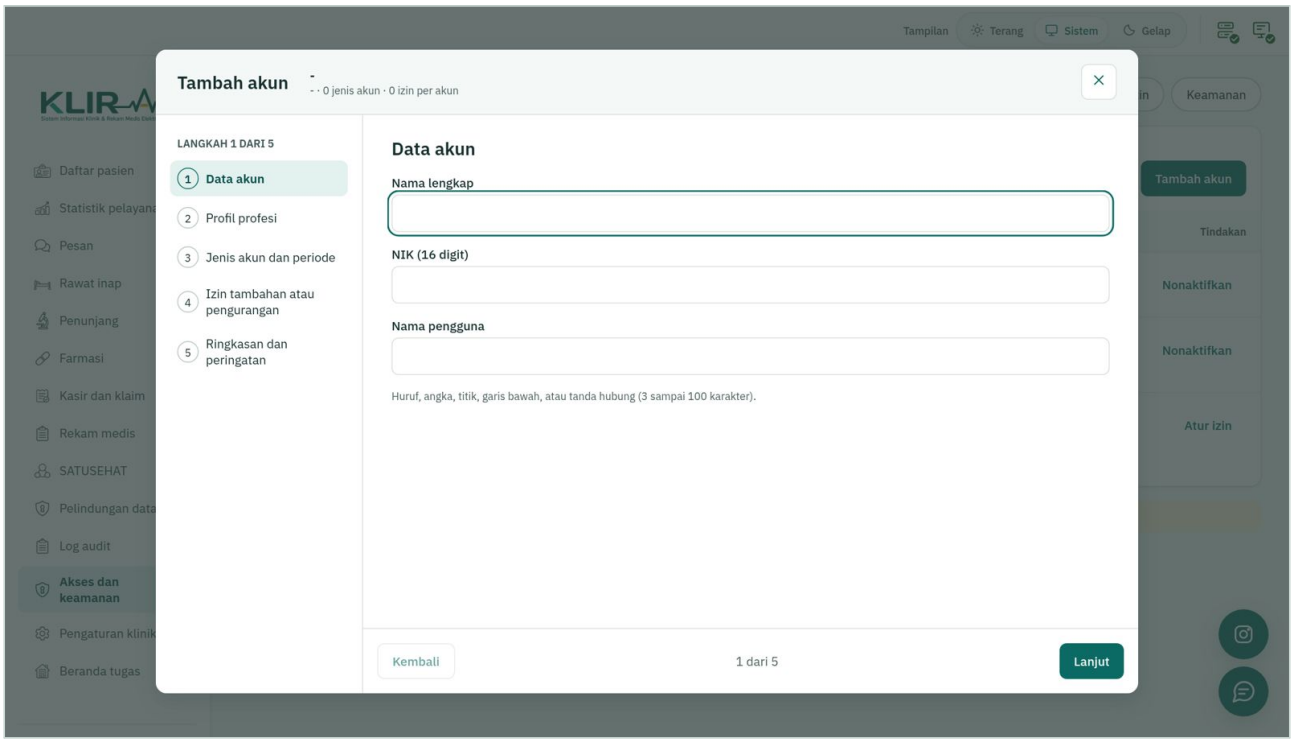
1. Pasien JKN didaftarkan dengan cara pembayaran **JKN**; isi nomor kartu, kelas hak, dan FKTP pada registrasi.
2. **Kasir dan klaim → Klaim JKN/BPJS → Siapkan klaim**. Modal 4 langkah: Kunjungan dan SEP → Diagnosis dan tindakan → Berkas klaim → Ringkasan. Kode harus sama dengan rekam medis; bila beda muncul peringatan.
3. Pantau kolom **Batas** (maksimum 6 bulan sejak selesai dilayani). Gunakan **Ubah status** untuk pengembalian berkas, pengajuan ulang, atau dibayar.
4. **Berkas dan SEP** membuka FPK, rekapitulasi, kuitansi, dan surat tanggung jawab mutlak.



Gambar 26. Penyiapan klaim.

6.4 Menambah akun dan menetapkan izin

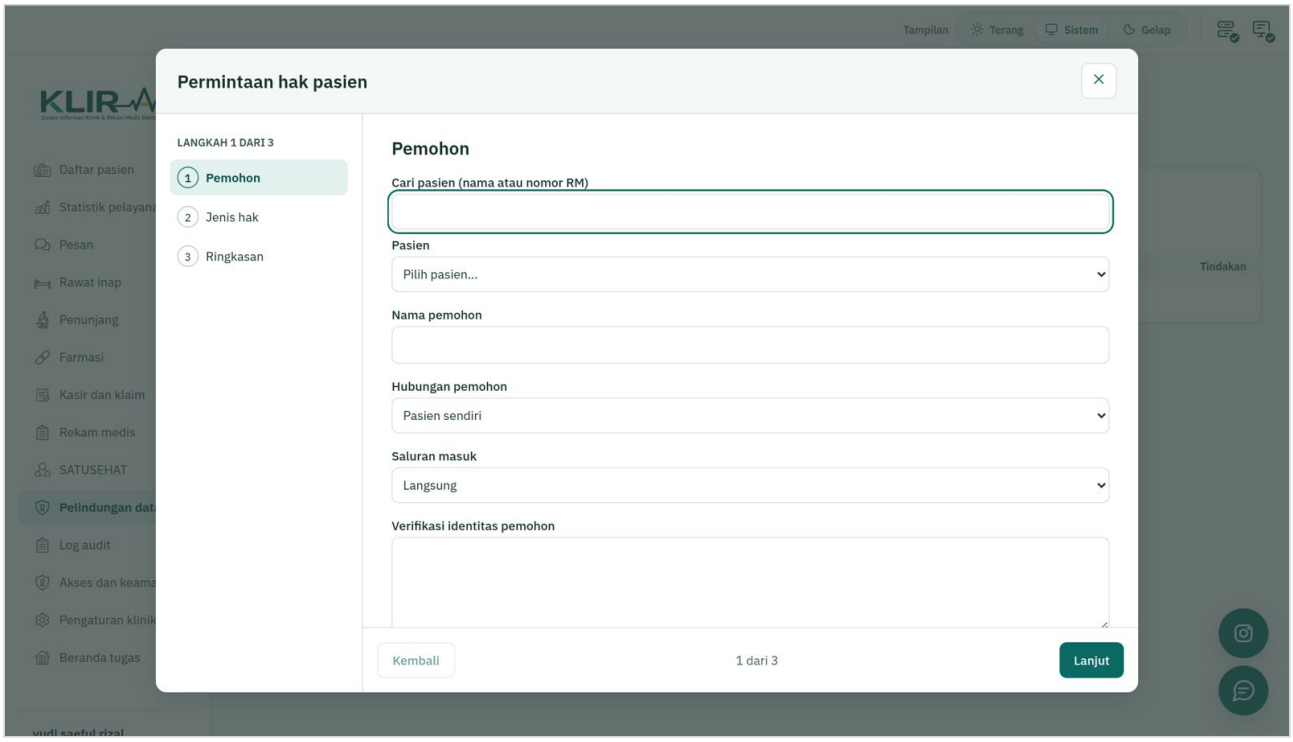
1. **Akses dan keamanan → Pengguna dan akses → Tambah akun**. Modal bertahap: Data akun → Profil profesi (SIP, IHS Number) → Jenis akun dan periode → Izin tambahan/pengurangan → Ringkasan dan peringatan.
2. Pilih satu atau beberapa jenis akun; isi periode mulai/selesai untuk rotasi.
3. Bila memberi izin berisiko, aplikasi menampilkan peringatan; isi alasan agar bisa lanjut. Peringatan tercatat di audit.
4. **Atur izin** pada baris akun untuk mengubah izin kemudian; **Nonaktifkan** untuk mencabut akun tanpa menghapus riwayat.



Gambar 27. Tambah akun.

6.5 Hak pasien dan pelindungan data

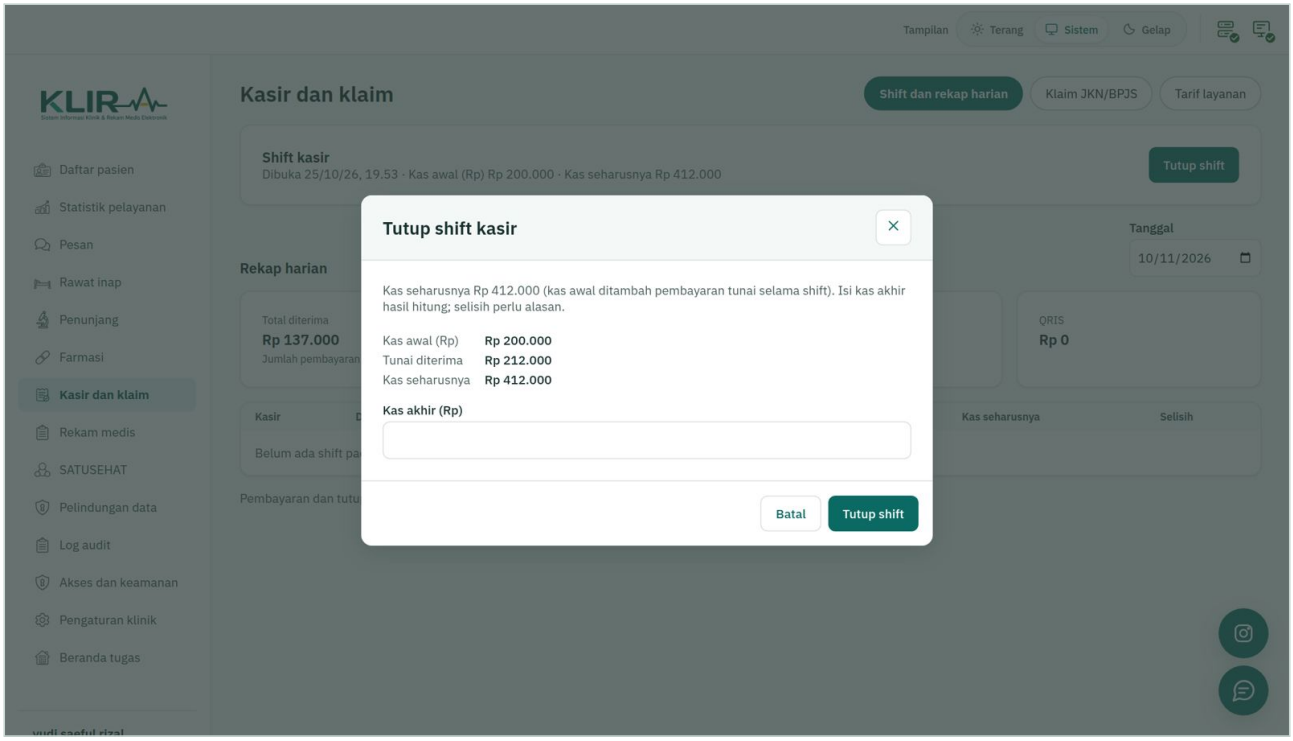
1. **Pelindungan data → Permintaan hak pasien → Catat permintaan**: Pemohon → Jenis hak (akses, salinan, koreksi, hapus/musnah, batasi, ekspor, keberatan) → Ringkasan.
2. Proses permintaan: Tinjau → Keputusan → Pelaksanaan → Notifikasi, dengan tenggat **3x24 jam**.
3. **Tarik persetujuan** pasien dilakukan dari tab Persetujuan dan pemberitahuan.
4. Dokumentasi lain: ROPA (5 langkah), DPIA, Insiden kebocoran (notifikasi 3x24 jam), Retensi dan pemusnahan (berita acara), Prosesor.



Gambar 28. Catat permintaan hak pasien.

6.6 Shift kasir

Kasir dan klaim → Shift dan rekap harian: buka shift dengan kas awal; saat tutup, aplikasi menghitung **kas seharusnya** (kas awal ditambah pembayaran tunai), isi kas akhir, dan bila ada selisih tuliskan alasan.



Gambar 29. Tutup shift kasir (kas seharusnya terhitung otomatis).

6.7 Mengelola website publik dan master

- **Pengaturan klinik → Profil klinik**: isi nama, kode registrasi, akreditasi; di bawahnya bagian **Website publik klinik** (slug, domain, judul, warna, kontak, jam operasional). Layanan dan jadwal website mengikuti master poli dan jadwal praktik.
- **Daftar pasien → Poli / Praktisi / Jadwal praktik**: tambah atau ubah master dengan satu bentuk modal yang sama.
- **Pengaturan klinik → Backup**: cadangan data. Folder backup berisi data pasien dan diabaikan oleh git.

7. Tutorial per peran kerja

Peran	Mulai dari	Urutan kerja harian
Petugas pendaftaran	Daftar pasien	Cari pasien (nama/RM/NIK) → bila baru: Registrasi pasien baru (termasuk general consent) → Daftarkan kunjungan → pantau antrean
Perawat/bidan	Daftar pasien	Panggil pasien → Skrining (tanda vital) → Simpan dan sahkan; catatan harian bagi pasien rawat inap
Dokter/DPJP	Daftar pasien	Periksa → SOAPIE (diagnosis ICD-10, resep, order lab, tindak lanjut) → Simpan dan sahkan; kemudian resume dan surat
Analis lab	Daftar pasien / Penunjang	Ambil spesimen → Hasil lab (hasil, interpretasi, validasi)
Apoteker	Daftar pasien / Farmasi	Telaah resep (3 telaah) → tandai disiapkan → Serahkan obat setelah lunas; kelola stok di Farmasi
Kasir	Daftar pasien / Kasir dan klaim	Buka shift → Pembayaran → Tutup kunjungan → tutup shift
Petugas klaim	Kasir dan klaim	Siapkan klaim → berkas dan SEP → pantau batas 6 bulan → ubah status
Perekam medis	Rekam medis	Pengkodean ICD → arsip otomatis → resume/surat → tinjau perbaikan → permintaan pembukaan dan penyampaian
Pimpinan	Akses dan keamanan	Kelola akun, jenis akun, izin, tinjau peringatan dan permintaan perbaikan; statistik pelayanan

Peran	Mulai dari	Urutan kerja harian
Petugas PDP	Beranda tugas	Permintaan hak pasien → ROPA/DPIA → insiden → retensi dan pemusnahan
Auditor	Log audit	Lihat log dan laporan (hanya baca)

8. Catatan simulasi dan pemecahan masalah

Temuan dari simulasi

Hal	Pengamatan	Saran
Alamat registrasi	Mengetik alamat tanpa memilih hasil pencarian wilayah membuat langkah tidak lanjut ("Wilayah tidak ditemukan").	Ketik kelurahan/kecamatan, lalu klik salah satu hasil. Teks petunjuk sudah ada, tetapi mudah terlewat.
Draf otomatis	Membuka ulang modal skrining/pemeriksaan langsung melompat ke langkah terakhir yang diisi.	Gunakan daftar langkah di kiri untuk kembali ke langkah mana pun.
Stok kurang	Telaah dan serah terima memunculkan peringatan karena stok tercatat 9 dari kebutuhan 10 botol.	Perbaiki lewat Mutasi stok, atau setujui dengan alasan (tercatat di audit).
Data obat contoh	Satu-satunya obat di master adalah Paracetamol infus (satuan Botol), sehingga resep demam memakai aturan "3 x 1 tablet" yang tidak sesuai bentuknya.	Tambahkan obat dari katalog KFA di Farmasi sebelum uji lanjutan.
SATUSEHAT	Halaman hanya menampilkan "segera tersedia".	Menunggu kredensial dan registrasi sistem dari pihak ketiga.
Rawat inap tanpa antrean	Baris kunjungan rawat inap langsung pada data uji menampilkan antrean "-" dan label Rawat inap.	Sesuai pengamatan; kunjungan itu tidak melalui antrean poli.

Cakupan simulasi

- **Dieksekusi lewat antarmuka**: registrasi, kunjungan, skrining, pemeriksaan SOAPIE, telaah resep, pembayaran, serah terima obat, tutup kunjungan, pengkodean ICD.
- **Dibuka dan difoto saja**: resume dan surat, admisi rawat inap, tambah akun, penyiapan klaim, permintaan hak pasien, ROPA, tutup shift.
- **Tidak disimulasikan**: order lab sampai hasil, rawat inap berjalan, klaim sampai dibayar, pemusnahan, pesan WhatsApp/Instagram, SATUSEHAT (belum ada), dan uji beban/keamanan.
- Simulasi tidak menggantikan uji otomatis proyek (608 uji) maupun pemeriksaan kode independen (Tahap B) yang menurut ringkasan belum dijalankan.

Pemecahan masalah umum

Gejala	Penyebab dan tindakan
Tidak bisa masuk	Pastikan nama pengguna dan kata sandi benar; akun awal wajib diganti pada login pertama. Pimpinan dapat menonaktifkan/mengatur akun di Akses dan keamanan.
Menu tidak muncul	Akun belum memiliki izin fitur tersebut. Minta pimpinan menambah jenis akun atau izin; membuka alamat langsung menampilkan "tidak diizinkan" dan tercatat di audit.
Tombol tindakan tidak ada pada baris	Tombol mengikuti tahap dan izin akun; pastikan tahap sebelumnya selesai (mis. resep harus berstatus Siap sebelum diserahkan) dan akun punya izin fitur terkait.
Isian hilang saat modal tertutup	Draf tersimpan otomatis di server; buka lagi modal yang sama dari baris pasien.
Serah obat ditolak	Stok tercatat kurang atau resep belum Siap. Selesaikan telaah, tambah stok, atau setujui dengan alasan.

Gejala	Penyebab dan tindakan
Tutup kunjungan ditolak	Periksa keempat syarat di modal; bila belum lunas muncul peringatan dengan alasan wajib.
Layar panggilan tanpa suara	Klik "Aktifkan suara" sekali (kebijakan autoplay peramban); pasang suara bahasa Indonesia di perangkat.
Server tidak merespons	Jalankan ulang aplikasi dengan `npm start` (butuh .env berisi DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, KUNCI_ENKRIPSI).

9. Lampiran

9.1 Daftar modal

Kelompok	Modal
Pelayanan klinik	Registrasi pasien baru · Pendaftaran kunjungan · Skrining · Pemeriksaan klinis · Persetujuan tindakan · Resume medis dan surat rujukan · Admisi rawat inap · Ubah penempatan · Catatan harian (CPPT) · Pemulangan rawat inap · Order lab · Ambil spesimen · Hasil lab · Telaah dan siapkan resep · Mutasi stok · Master obat · Perbaiki catatan · Tinjau permintaan perbaikan
Panel samping	Riwayat · Salin dari kunjungan sebelumnya · Favorit dan templat · Family folder
Kasir dan klaim	Pembayaran dan serah terima obat · Tutup kunjungan · Buka dan tutup shift · Penyiapan klaim · Ubah status klaim
Rekam medis	Permintaan pembukaan · Penyampaian rekam medis · Pengkodean ICD · Buat laporan
Akun dan pengaturan	Pembuatan akun dan penugasan · Atur izin akun · Buat/ubah jenis akun · Tambah/ubah master dan profil
Pelindungan data	Permintaan hak pasien · ROPA · DPIA · Insiden kebocoran · Pemusnahan · Prosesor · Versi teks pemberitahuan · Catat tarik persetujuan
Komponen umum	Konfirmasi · Peringatan (alasan wajib, tercatat) · Panel detail (baca-saja)

9.2 Kata kunci

Istilah	Arti
SOAPIE	Subjective, Objective, Assessment, Plan, Implementation, Evaluation: format catatan pemeriksaan
ICD-10 / ICD-9 CM	Klasifikasi diagnosis / tindakan; dikodekan perekam medis
KFA	Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes; sumber master obat
LOINC	Kode standar pemeriksaan laboratorium
SATUSEHAT	Platform interoperabilitas data kesehatan Kemenkes
SEP	Surat Eligibilitas Peserta JKN
CPPT	Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (rawat inap)
DPJP	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
ROPA / DPIA	Rekaman kegiatan pemrosesan data / penilaian dampak pelindungan data
PPDP	Petugas pelindungan data pribadi

9.3 Kebiasaan kerja yang disarankan

- Selalu pilih hasil pencarian (wilayah, pasien, ICD, obat) dengan klik; bukan hanya mengetik.
- Gunakan tombol Riwayat dan Salin dari kunjungan sebelumnya untuk mengurangi pengetikan ulang.
- Tab terakhir yang dibuka di tiap halaman diingat selama sesi; tombol Kembali peramban menutup modal, bukan keluar halaman.
- Alasan pada peringatan ditulis jelas: alasan itu dibaca auditor di Log audit.

- Cadangkan data secara berkala lewat Pengaturan klinik → Backup dan simpan folder backup di tempat aman (berisi data pasien).